G5 — Sensation de maladie · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v1

LOT_005 audité · Phase A + Phase B (DX.1–15) · 94 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 56 EX · 22 AP · 16 SPE

🧭 Carte mentale G5 · 60 secondes avant de répondre

EX Examen — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

AP Approfondissement — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

SPE · spécialité Spécialiste — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

Les 3 questions réflexes devant « je ne me sens pas bien »

1. **Danger maintenant ?** Constantes complètes et **glycémie capillaire en 10 minutes** : choc, qSOFA ≥ 2, lactate, déficit focal, douleur thoracique ou dyspnée, hypotension avec Na bas et K haut.
2. **Foyer ou signe d'appel ?** Urine, poumon, peau, abdomen, cathéter ; perte de poids, sueurs, adénopathie ; changement de médicament.
3. **Sinon :** anamnèse avec un proche et **liste complète des médicaments**, examen de la tête aux pieds, bilan de base (ECG, ionogramme, calcium, créatinine, glucose, FSC, CRP, TSH), PHQ-2 ; **réévaluer à 48–72 h**.

🦠 Infection

- Pas de fièvre ≠ pas d'infection chez le sujet âgé (DX.4)
- Bandelette positive sans symptôme = ne pas traiter (DX.1)
- CRB-65 : 0 domicile, 3–4 hôpital en urgence (DX.3)
- Virose = diagnostic d'exclusion (DX.9)

⚗️ Ions · métabolisme

- Na < 125 + symptômes → NaCl 3 % ; ≤ 10 mmol/L le 1er jour (DX.2)
- K élevé + ECG anormal → calcium i.v. (DX.2)
- Glycémie < 4,0 ou > 11 mmol/L ; Hb, TSH (DX.10)

💊 Médicaments · psyché

- 12,2 % des plaintes non spécifiques, 40 % reconnus (DX.8)
- Thiazide + ISRS → natrémie ; myosis + bradypnée → naloxone
- PHQ-9 ≥ 10 → entretien ; somatique d'abord (DX.6)

🦴 Ceintures · organe

- > 50 ans, raideur > 45 min, CRP ↑ → PMR ; exclure infection et cancer (DX.5)
- Trouble visuel, mâchoire → corticoïde sans attendre la biopsie
- Aucune orientation → évaluation gériatrique, suivi (DX.7)

🚩 Ordre d'exclusion

1. E1 Sepsis (DX.11)
2. E2 AVC (DX.12)
3. E3 SCA atypique (DX.13)
4. E4 Crise surrénalienne (DX.15)
5. E5 Trouble ionique sévère (DX.2)
6. E6 Cancer (DX.14)

Bâle : maladie grave à 30 jours chez 59 % ; diagnostic des urgences correct dans 46 % ; AVC manqué dans 64 % des présentations non spécifiques.

① Raisonner · 31 Q · avant de nommer le diagnostic

Plainte non spécifique de la personne âgée = urgence présumée. Constantes et glycémie capillaire d'abord ; puis sepsis, AVC, SCA, crise surrénalienne, trouble ionique, cancer, avant la cause banale.

Q1 **EX** **DX.7 · premier geste** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 84 ans, vivant seule, est amenée aux urgences car elle « ne se sent pas bien » depuis 2 jours. Elle ne localise aucune plainte. Pas de douleur rapportée. Traitement : hydrochlorothiazide et sertraline.

Quelle est la première étape la plus appropriée ?

- **A** Constantes complètes et glycémie capillaire
- **B** Bandelette urinaire systématique
- **C** PHQ-9 pour dépister une dépression
- **D** Scanner cérébral sans contraste
- **E** Retour à domicile et contrôle chez le médecin de famille

Q2 **EX** **DX.11 · afébrile et confuse** Prise en charge · urgences

Une femme de 86 ans, résidente d'EMS, est confuse depuis ce matin. T 36,4 °C, FC 108/min, PA 94/58 mmHg, FR 24/min, SpO2 93 %. Aucun foyer évident à l'examen.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Hémocultures, lactate, antibiotique i.v. dans l'heure
- **B** Attendre la fièvre avant tout antibiotique
- **C** Scanner cérébral avant toute autre mesure
- **D** Rechercher le foyer, puis décider de l'antibiotique
- **E** Halopéridol pour la confusion et surveillance

Q3 **EX** **DX.12 · déficit brutal** Évaluation / diagnostic · domicile

Un homme de 74 ans est trouvé par son épouse à 9 h, incapable de parler correctement, le bras droit faible. Elle l'avait vu normal la veille à 22 h. À l'arrivée de l'ambulance, il est somnolent.

Quelle mesure doit précéder toutes les autres ?

- **A** Scanner cérébral sans contraste
- **B** Altéplase 0,9 mg/kg
- **C** Électroencéphalogramme
- **D** Glycémie capillaire
- **E** Ponction lombaire

Q4 **EX** **DX.12 · heure de référence** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 79 ans se réveille à 7 h avec une hémiparésie gauche. Elle s'était couchée à 23 h sans plainte. Glycémie 6,1 mmol/L. Le scanner sans contraste ne montre pas d'hémorragie.

Quelle heure de début faut-il retenir pour la décision de reperfusion ?

- **A** 7 h, heure du réveil
- **B** L'heure d'arrivée aux urgences
- **C** L'heure du scanner
- **D** Le milieu de la nuit, par convention
- **E** 23 h, dernier état normal connu

Q5 **EX** **DX.13 · dyspnée du diabétique** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme diabétique de 70 ans consulte pour un malaise et un essoufflement apparus il y a 2 heures. Il n'a aucune douleur thoracique. FC 96/min, PA 138/82 mmHg, SpO2 95 %.

Quel examen faut-il réaliser en premier ?

- **A** Radiographie du thorax
- **B** D-dimères
- **C** Spirométrie
- **D** Échocardiographie transthoracique programmée
- **E** ECG 12 dérivations dans les 10 minutes

Q6 **EX** **DX.15 · choc et corticoïdes** Prise en charge · urgences

Un homme de 66 ans sous prednisone 20 mg/j depuis 6 mois pour une polymyalgie a arrêté son traitement il y a 4 jours. Il vomit, se sent très mal. PA 78/45 mmHg malgré 1 L de cristalloïde, Na 127 mmol/L, glycémie 3,9 mmol/L.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Hydrocortisone 100 mg i.v. immédiatement
- **B** Test à la corticotropine avant tout traitement
- **C** Noradrénaline seule
- **D** Restriction hydrique pour l'hyponatrémie
- **E** Reprendre la prednisone 20 mg par voie orale

Q7 **EX** **DX.2 · hyponatrémie et convulsion** Prise en charge · urgences

Une femme de 78 ans, sous hydrochlorothiazide, est amenée après une crise convulsive. Elle vomit et reste somnolente. Na 116 mmol/L, glycémie 6,4 mmol/L.

Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?

- **A** Restriction hydrique à 500 mL par jour
- **B** NaCl 0,9 % 2 L en 2 heures
- **C** Bolus de NaCl 3 % 100 à 150 mL en soins intensifs
- **D** Tolvaptan per os
- **E** Attendre l'osmolalité urinaire avant toute correction

Q8 **EX** **DX.14 · lombalgie nocturne** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 68 ans, traité il y a 2 ans pour un cancer de la prostate, se sent mal et souffre depuis 2 semaines d'une douleur dorsale qui le réveille la nuit. Force et sensibilité normales. Pas de trouble sphinctérien.

Quel examen faut-il demander ?

- **A** Radiographie lombaire standard
- **B** IRM de tout le rachis en urgence
- **C** Scintigraphie osseuse programmée
- **D** Dosage du PSA seul
- **E** Physiothérapie et réévaluation à 6 semaines

Q9 **EX** **DX.11 · remplissage** Prise en charge · urgences

Un homme de 80 ans, 70 kg, a une pneumonie. PA 84/50 mmHg, lactate 4,1 mmol/L. Les hémocultures sont prélevées et la ceftriaxone est en cours.

Quel remplissage est le plus approprié ?

- **A** Glucose 5 % 1 L en 1 heure
- **B** Albumine 20 % en première intention
- **C** 500 mL de NaCl 0,9 % sur 24 heures
- **D** Cristalloïde équilibré ≥ 30 mL/kg en 3 h
- **E** Pas de remplissage avant la noradrénaline

Q10 **EX** **DX.13 · sus-décalage** Prise en charge · urgences

Une femme de 72 ans se plaint d'un malaise et de nausées depuis 1 heure. L'ECG montre un sus-décalage de ST de 2 mm en DII, DIII et aVF. La première troponine hs n'est pas encore revenue.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attendre la troponine de 1 heure
- **B** Reperfusion coronaire sans attendre la troponine
- **C** Échocardiographie de stress
- **D** Antiémétique et ECG de contrôle à 6 heures
- **E** Scanner thoracique injecté pour exclure d'abord une embolie

Q11 **EX** **DX.10 · décompensation diabétique** Prise en charge · urgences

Un homme de 24 ans, diabétique de type 1, se sent mal depuis 2 jours. Il vomit et respire profondément. Glycémie 26 mmol/L.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Insuline glargine 20 U s.c.
- **B** Cétonémie et gaz du sang, puis perfusion
- **C** HbA1c pour juger du déséquilibre
- **D** Insuline rapide i.v. en bolus avant tout bilan
- **E** Métoclopramide et retour à domicile

Q12 **EX** **DX.6 · idées suicidaires** Prise en charge · cabinet

Une femme de 58 ans consulte pour un malaise diffus depuis 2 mois. Le bilan somatique est normal. PHQ-9 = 22. À la question directe, elle dit avoir prévu de prendre tous ses comprimés ce week-end.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Sertraline 50 mg et contrôle dans 2 semaines
- **B** Psychothérapie programmée dans le mois
- **C** Compléter d'abord le bilan endocrinien
- **D** Évaluation psychiatrique urgente le jour même
- **E** Lui demander de rappeler si les idées persistent

Q13 **EX** **DX.8 · bradypnée et myosis** Prise en charge · domicile

Une femme de 81 ans sous patch de fentanyl est retrouvée somnolente. FR 7/min, pupilles en myosis serré, SpO2 86 %. Glycémie 6,0 mmol/L.

Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?

- **A** Flumazénil 0,3 mg i.v.
- **B** Scanner cérébral avant tout traitement
- **C** Naloxone 0,4 à 2 mg i.v. et oxygène
- **D** Acétylcystéine i.v.
- **E** Glucose 20 % i.v.

Q14 **EX** **DX.1 · pyélonéphrite fébrile** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 52 ans a de la fièvre à 39,2 °C, des frissons et une douleur lombaire droite depuis hier. PA 128/76 mmHg, FC 98/min. Bandelette : leucocytes et nitrites positifs.

Quel examen faut-il ajouter avant le traitement ?

- **A** Scintigraphie rénale
- **B** Cystoscopie
- **C** Urographie i.v.
- **D** Échographie pour exclure un obstacle
- **E** Aucun examen : fosfomycine en dose unique

Q15 **EX** **DX.4 · raideur de nuque** Prise en charge · urgences

Un homme de 71 ans est amené pour confusion et fièvre à 38,9 °C depuis 12 heures. Nuque raide. PA 132/80 mmHg. Pas de déficit focal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Ponction lombaire, puis antibiotique selon le résultat
- **B** IRM cérébrale avant tout antibiotique
- **C** Paracétamol et réévaluation à 6 heures
- **D** Antiviral seul en attendant la PCR
- **E** Antibiotique sans attendre la ponction lombaire

Q16 **EX** **DX.14 · hypercalcémie** Prise en charge · urgences

Un homme de 74 ans, fumeur, est confus depuis une semaine, boit beaucoup et urine souvent. Calcémie corrigée 3,4 mmol/L, créatinine 118 µmol/L. Perte de 6 kg en 3 mois.

Quelle est la première mesure thérapeutique ?

- **A** Zolédronate 4 mg d'emblée, sans perfusion préalable
- **B** Restriction hydrique
- **C** Hydratation i.v.
- **D** Calcium et vitamine D
- **E** Biopsie avant tout traitement

Q17 **EX** **DX.9 · virose d'exclusion** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 76 ans consulte en saison grippale pour fièvre et malaise depuis hier. FR 23/min, PA 98/60 mmHg, elle est un peu ralentie. Elle souhaite « juste un médicament contre la grippe ».

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Oseltamivir 75 mg deux fois par jour à domicile
- **B** Paracétamol et contrôle dans 48 heures
- **C** Urgences : hémocultures et antibiotique
- **D** Test grippe puis décision selon le résultat
- **E** Vaccin contre la grippe le jour même

Q18 **AP** **DX.7 · comportement de maladie** Mécanismes · hôpital

Un étudiant demande pourquoi une femme de 80 ans avec une infection débutante se dit « malade » sans fièvre, sans toux ni signe d'organe, avec fatigue, anorexie et retrait.

Quel mécanisme explique le mieux cette sensation de maladie ?

- **A** Lésion directe des neurones par les bactéries
- **B** Hypoglycémie réactionnelle
- **C** Déficit primaire en sérotonine
- **D** Hyperthermie centrale
- **E** Cytokines relayées au cerveau par la microglie

Q19 **AP** **DX.2 · correction trop rapide** Mécanismes · hôpital

Une femme de 72 ans, alcoolique, admise avec Na 112 mmol/L, a reçu des perfusions : Na 129 mmol/L 24 heures plus tard. Au 3e jour, elle devient dysarthrique, tétraparétique et somnolente.

Quel mécanisme est le plus probable ?

- **A** Démyélinisation osmotique du tronc cérébral
- **B** Œdème cérébral par hyponatrémie persistante
- **C** AVC hémorragique
- **D** Encéphalopathie hypoglycémique
- **E** Méningite

Q20 **AP** **DX.15 · pigmentation** Mécanismes · cabinet

Une femme de 44 ans se sent mal depuis des mois. Elle a une hyperpigmentation des plis palmaires et des gencives, une hypotension orthostatique et une kaliémie à 5,5 mmol/L.

Quel mécanisme explique l'hyperpigmentation ?

- **A** Excès d'ACTH stimulant les mélanocytes
- **B** Déficit en aldostérone
- **C** Excès de cortisol
- **D** Hémochromatose associée
- **E** Photosensibilisation médicamenteuse

Q21 **AP** **DX.11 · définition Sepsis-3** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 75 ans a une pneumonie. Ses plaquettes passent de 220 à 95 G/L et sa créatinine de 85 à 190 µmol/L en 24 heures. Il reste normotendu.

Quelle est la classification la plus appropriée ?

- **A** Pneumonie simple
- **B** Choc septique
- **C** SIRS
- **D** Sepsis
- **E** Bactériémie

Q22 **AP** **DX.4 · pourquoi pas de fièvre** Mécanismes · EMS

Une infirmière d'EMS s'étonne qu'une résidente de 91 ans avec une pneumonie radiologique n'ait jamais eu de fièvre.

Quelle explication est la plus juste ?

- **A** Absence probable d'infection bactérienne active
- **B** Prise cachée d'antipyrétique
- **C** Réponse inflammatoire atténuée avec l'âge
- **D** Hypothermie de l'EMS
- **E** Infection purement virale

Q23 **AP** **DX.9 · procalcitonine** Prise en charge · cabinet

Une femme de 39 ans a une toux fébrile depuis 3 jours, sans signe de gravité ni foyer à l'auscultation. Procalcitonine 0,08 µg/L.

Quelle décision est la plus appropriée ?

- **A** Amoxicilline 7 jours
- **B** Pas d'antibiotique
- **C** Lévofloxacine 7 jours
- **D** Hospitalisation pour antibiotique i.v.
- **E** Doxycycline en réserve

Q24 **AP** **DX.13 · infarctus de type 2** Mécanismes · hôpital

Un homme de 79 ans hospitalisé pour méléna a une Hb à 62 g/L. Il se sent mal, avec une oppression thoracique. Troponine hs en montée, sous-décalage ST diffus.

Quel mécanisme est le plus probable ?

- **A** Rupture de plaque avec thrombus (type 1)
- **B** Infarctus lié à une angioplastie
- **C** Mort cardiaque avant prélèvement (type 3)
- **D** Déséquilibre apport-besoin (type 2)
- **E** Myocardite virale

Q25 **AP** **DX.6 · délai de l'antidépresseur** Prise en charge · cabinet

Une femme de 54 ans a débuté la sertraline 50 mg pour une dépression il y a 10 jours. Elle est déçue : « je ne sens encore rien ».

Quelle information est la plus juste ?

- **A** Échec : changer de molécule maintenant
- **B** Arrêter brutalement et réévaluer
- **C** Effet attendu en 2 à 4 semaines
- **D** Doubler aussitôt à 200 mg
- **E** Ajouter une benzodiazépine au long cours

Q26 **SPE · Médecine intensive** **DX.11 · choc septique** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 68 ans a une péritonite. Après 30 mL/kg de cristalloïde, il faut de la noradrénaline pour maintenir une PAM ≥ 65 mmHg ; lactate 3,2 mmol/L.

Quelle est la classification la plus appropriée ?

- **A** Sepsis sans choc
- **B** Choc hypovolémique pur
- **C** Choc cardiogénique
- **D** Bactériémie isolée
- **E** Choc septique

Q27 **SPE · Neurologie** **DX.12 · occlusion de gros vaisseau** Prise en charge · urgences

Une femme de 70 ans a une hémiplégie droite et une aphasie depuis 2 heures. Scanner sans hémorragie ; altéplase débutée. L'angio-scanner montre une occlusion de l'artère cérébrale moyenne proximale.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Attendre l'effet de l'altéplase 24 heures
- **B** Aspirine 300 mg immédiatement
- **C** IRM de contrôle à 48 heures
- **D** Héparine i.v. à dose curative
- **E** Thrombectomie et transfert immédiat

Q28 **SPE · Endocrinologie** **DX.15 · confirmer le diagnostic** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 49 ans stabilisé après une crise surrénalienne présumée doit être exploré. Il ne reçoit plus d'hydrocortisone depuis la veille, sur avis endocrinologique.

Quel examen est la référence pour poser le diagnostic ?

- **A** Cortisol plasmatique aléatoire en soirée
- **B** Test à la corticotropine 250 µg
- **C** Natrémie et kaliémie
- **D** Scanner des surrénales
- **E** Anticorps anti-TPO

Q29 **SPE · Cardiologie** **DX.13 · score GRACE** Prise en charge · hôpital

Un homme de 78 ans a un NSTEMI confirmé (troponine hs dynamique). Il est stable, sans douleur réfractaire ni arythmie. Score GRACE 156.

Quel délai de coronarographie est le plus approprié ?

- **A** Sous 24 heures
- **B** Sous 2 heures
- **C** Programmée à 3 mois
- **D** Aucune, traitement médical seul
- **E** Après un test d'effort

Q30 **SPE · Gériatrie** **DX.7 · confusion fluctuante** Évaluation / diagnostic · EMS

Une résidente d'EMS de 87 ans est apathique depuis 2 jours, avec des moments de lucidité. Elle ne peut pas compter de 20 à 1 et son discours est décousu. Constantes et glycémie normales.

Quelle démarche est la plus appropriée ?

- **A** Diagnostic de démence évolutive
- **B** Dépression : PHQ-9 et antidépresseur
- **C** CAM, puis cause du delirium
- **D** Neuroleptique et observation
- **E** Scanner cérébral seul

Q31 **SPE · Oncologie** **DX.14 · neutropénie fébrile** Prise en charge · urgences

Une femme de 59 ans, sous chimiothérapie pour un cancer du sein, se sent mal depuis ce matin. T 38,7 °C. PNN 0,3 G/L. PA 112/70 mmHg.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attendre le résultat des cultures
- **B** Antipyrétique et contrôle le lendemain
- **C** Chercher d'abord un foyer par scanner thoraco-abdominal
- **D** Facteur de croissance seul
- **E** Hémocultures et antibiotique dans l'heure

② Discriminer · 46 Q · un signe, un examen qui tranche

Les 15 DX du LOT face à face : un signe, un examen qui tranche, une conduite. Les questions AP (bleu) et SPE (violet) sont mêlées aux EX : filtrez par niveau en haut.

Q32 **EX** **DX.1 · cystite simple** Prise en charge · cabinet

Une femme de 29 ans, non enceinte, sans antécédent, a depuis hier des brûlures mictionnelles, une pollakiurie et une douleur sus-pubienne. Pas de fièvre, pas de douleur lombaire, pas de pertes vaginales.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Fosfomycine 3 g per os en dose unique
- **B** ECBU et attendre le résultat avant de traiter
- **C** Ceftriaxone 2 g i.v.
- **D** Échographie rénale urgente
- **E** Amoxicilline-clavulanate 7 jours

Q33 **EX** **DX.1 · homme fébrile** Prise en charge · cabinet

Un homme de 67 ans a depuis 2 jours des brûlures mictionnelles et une fièvre à 38,3 °C. PA 136/82 mmHg, FC 92/min. Pas de sonde, pas d'antécédent urologique.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Fosfomycine 3 g en dose unique
- **B** Aucun antibiotique, boissons abondantes
- **C** ECBU, puis traitement d'une infection compliquée
- **D** Bandelette seule et traitement de 3 jours
- **E** Antibiotique seulement après culture positive à 72 h

Q34 **EX** **DX.1 vs DX.11 · urosepsis** Prise en charge · urgences

Une femme de 79 ans a des brûlures mictionnelles depuis 3 jours. Ce matin, elle est confuse. T 38,8 °C, PA 92/54 mmHg, FR 24/min.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Prélèvements, puis antibiotique i.v. immédiat
- **B** Fosfomycine 3 g et retour à domicile
- **C** ECBU puis antibiotique adapté à l'antibiogramme
- **D** Imagerie cérébrale pour la confusion
- **E** Hydratation orale et contrôle demain

Q35 **EX** **DX.2 · hyponatrémie modérée** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 81 ans se sent faible et nauséeuse depuis une semaine. Elle est orientée, sans céphalée ni vomissement. Na 128 mmol/L. Traitement : hydrochlorothiazide et citalopram.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Bolus de NaCl 3 %
- **B** Tolvaptan d'emblée
- **C** Imagerie cérébrale
- **D** Aucune mesure : valeur sans importance à cet âge
- **E** Osmolalité, natriurèse et évaluation de la volémie

Q36 **EX** **DX.2 · hyperkaliémie et ECG** Prise en charge · urgences

Un homme de 76 ans en insuffisance rénale chronique se sent mal et faible. K 7,1 mmol/L sur un prélèvement non hémolysé. L'ECG montre des ondes T pointues et un QRS élargi.

Quelle mesure est la plus urgente ?

- **A** Chlorure de potassium i.v.
- **B** Calcium i.v. immédiat
- **C** Restriction alimentaire en potassium
- **D** Dialyse programmée la semaine suivante
- **E** Répéter le dosage dans 24 heures

Q37 **AP** **DX.2 vs DX.14 · calcémie à corriger** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 83 ans dénutrie se sent mal. Calcémie totale 2,12 mmol/L, albumine 24 g/L. Elle n'a ni paresthésie ni crampe.

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** Hypocalcémie à substituer d'emblée
- **B** Hypercalcémie maligne à traiter par zolédronate
- **C** Dosage de la PTH en urgence
- **D** Calculer la calcémie corrigée par l'albumine
- **E** Valeur normale pour l'âge, aucune suite

Q38 **EX** **DX.3 · CRB-65** Prise en charge · cabinet

Un homme de 84 ans est confus depuis hier. Toux, T 38,4 °C, FR 32/min, PA 86/54 mmHg. La radiographie montre un infiltrat lobaire droit nouveau.

Quelle orientation est la plus appropriée ?

- **A** Hospitalisation urgente, soins intensifs à discuter
- **B** Amoxicilline à domicile
- **C** Contrôle radiologique à 6 semaines
- **D** Hospitalisation à envisager selon le contexte
- **E** Antibiotique si la CRP dépasse 100 mg/L

Q39 **EX** **DX.3 · pneumonie simple** Prise en charge · cabinet

Un homme de 42 ans, sans comorbidité, a de la fièvre et une toux productive depuis 3 jours. FR 18/min, PA 128/80 mmHg, orienté. La radiographie montre un infiltrat nouveau du lobe inférieur gauche.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Ceftriaxone i.v. à l'hôpital
- **B** Aucun antibiotique, pneumonie probablement virale
- **C** Oseltamivir seul
- **D** Amoxicilline per os à domicile
- **E** Macrolide seul d'emblée

Q40 **EX** **DX.3 · radiographie normale** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 88 ans, en EMS, chute et se dit fatiguée. T 37,9 °C, FR 24/min, SpO2 90 %, crépitants de la base droite. La radiographie du thorax est normale.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Exclure la pneumonie et chercher une autre cause
- **B** Répéter la radiographie dans 6 semaines
- **C** Bronchoscopie
- **D** Procalcitonine unique pour décider
- **E** Échographie pulmonaire ou scanner thoracique

Q41 **EX** **DX.4 · abcès** Prise en charge · hôpital

Un homme de 63 ans, diabétique, se sent mal depuis une semaine. T 38,6 °C, CRP 210 mg/L. Le scanner montre un abcès hépatique de 6 cm. Il reçoit une antibiothérapie i.v. adaptée depuis 48 heures, sans amélioration.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Doubler la dose d'antibiotique
- **B** Arrêter l'antibiotique et observer
- **C** Ajouter un antifongique empirique
- **D** Corticoïdes pour la fièvre
- **E** Drainage de l'abcès

Q42 **EX** **DX.4 · douleur disproportionnée** Prise en charge · urgences

Un homme de 58 ans se sent très mal depuis 12 heures. Il a une douleur intense de la cuisse droite, disproportionnée par rapport à un érythème discret. T 38,7 °C, FC 118/min, PA 102/64 mmHg.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Antibiotique oral et contrôle à 48 heures
- **B** Avis chirurgical urgent
- **C** Doppler veineux et anticoagulation
- **D** Anti-inflammatoire et repos
- **E** IRM programmée la semaine suivante

Q43 **EX** **DX.4 · pas de foyer** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 74 ans est hospitalisée pour malaise et fièvre. Constantes stables. Examen complet, radiographie du thorax, urine et hémocultures sans foyer après 72 heures.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Scanner, puis cause non infectieuse
- **B** Antibiothérapie empirique au long cours
- **C** Conclure à une fièvre virale et la renvoyer
- **D** Sortie sans suivi
- **E** Répéter le même bilan chaque jour

Q44 **EX** **DX.5 · ceintures** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 73 ans se sent mal depuis 6 semaines. Elle a mal aux deux épaules et aux hanches, avec une raideur matinale de 90 minutes. CRP 48 mg/L. FR et ACPA négatifs. Pas de céphalée, pas de trouble visuel.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- **A** Fibromyalgie
- **B** Polyarthrite rhumatoïde
- **C** Polymyalgie rhumatismale
- **D** Myopathie aux statines
- **E** Dépression avec plaintes somatiques

Q45 **EX** **DX.5 🚩 · trouble visuel** Prise en charge · cabinet

Un homme de 76 ans se sent mal depuis 3 semaines, avec céphalée temporale, douleur de la mâchoire en mastiquant et, ce matin, une vision floue de l'œil droit. CRP 92 mg/L.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Biopsie de l'artère temporale avant tout traitement
- **B** AINS et contrôle ophtalmologique à 2 semaines
- **C** IRM cérébrale programmée
- **D** Prednisone 15 mg par jour
- **E** Glucocorticoïde immédiat et avis spécialisé sous 24 h

Q46 **EX** **DX.5 vs DX.8 · CK sous statine** Prise en charge · cabinet

Un homme de 69 ans se sent faible depuis 3 semaines et peine à se lever d'une chaise. Son atorvastatine a été augmentée il y a un mois. CK 4 200 U/L, créatinine normale.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Poursuivre la statine et ajouter de la physiothérapie
- **B** Arrêter la statine, contrôler CK et créatinine
- **C** Prednisone pour une polymyalgie
- **D** Doubler la statine pour le risque cardiovasculaire
- **E** Électromyogramme avant toute mesure

Q47 **EX** **DX.6 · PHQ-9 positif** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 49 ans se sent « malade sans être malade » depuis 2 mois. Examen normal ; FSC, CRP, ionogramme, glycémie et TSH normaux. PHQ-9 = 14. Pas d'idée suicidaire.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Diagnostic de dépression sur le seul PHQ-9
- **B** Entretien clinique selon les critères DSM-5
- **C** Scanner thoraco-abdominal
- **D** Test à la corticotropine
- **E** Benzodiazépine au long cours

Q48 **EX** **DX.6 vs DX.13 · anxiété et thorax** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 61 ans, suivie pour trouble anxieux, se sent mal depuis 40 minutes avec oppression thoracique et dyspnée. Elle dit : « c'est encore mon angoisse ». FC 102/min, PA 148/90 mmHg.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Lorazépam et observation
- **B** Exercices respiratoires et retour à domicile
- **C** ECG et troponine hs
- **D** Sertraline à majorer
- **E** Avis psychiatrique urgent

Q49 **EX** **DX.7 · bilan de première intention** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 82 ans se sent mal depuis 3 jours. Constantes stables, glycémie capillaire 6,2 mmol/L, pas de douleur thoracique ni de déficit. L'examen ne trouve pas de foyer.

Quel bilan de première intention est le plus approprié ?

- **A** ECG, ionogramme, Ca, créatinine, glucose, FSC, CRP, TSH
- **B** Marqueurs tumoraux et scanner corps entier
- **C** IRM cérébrale, électroencéphalogramme et ponction lombaire
- **D** Test à la corticotropine et cortisol libre urinaire
- **E** Copeptine et MR-proADM

Q50 **EX** **DX.7 · bilan normal** Prise en charge · cabinet

Un homme de 79 ans consulte pour un malaise depuis 10 jours. Constantes, examen et bilan de base normaux. Il vit seul, avec une aide à domicile.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Revoir à 48 h et à une semaine
- **B** Rassurer et clore le dossier
- **C** Scanner thoraco-abdominal d'emblée
- **D** Antibiotique empirique
- **E** Hospitalisation systématique

Q51 **AP** **DX.7 · critères de sortie** Prise en charge · hôpital

Une femme de 85 ans, hospitalisée 4 jours pour une pneumonie traitée, se sent mieux. Constantes stables depuis 24 heures ; elle mange et boit seule. Sa fille demande si elle peut rentrer.

Quel élément faut-il encore vérifier avant la sortie ?

- **A** Normalisation complète de la CRP
- **B** Radiographie du thorax normalisée
- **C** Deux paires d'hémocultures de contrôle négatives
- **D** Absence de toute toux résiduelle
- **E** Mobilité, cognition et médicaments revus

Q52 **EX** **DX.8 · thiazide et ISRS** Prise en charge · cabinet

Une femme de 80 ans se sent confuse et nauséeuse depuis 10 jours. On a ajouté de l'hydrochlorothiazide il y a 3 semaines ; elle prend de la sertraline. Na 126 mmol/L, sans symptôme sévère.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Arrêter le thiazide et surveiller la natrémie
- **B** Bolus de NaCl 3 %
- **C** Augmenter la sertraline
- **D** Ajouter du furosémide
- **E** Poursuivre et refaire le dosage dans 3 mois

Q53 **EX** **DX.8 · paracétamol** Prise en charge · urgences

Une femme de 34 ans dit avoir avalé 12 g de paracétamol il y a 2 heures. Elle n'a aucun symptôme. Constantes normales.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Retour à domicile, car elle est asymptomatique
- **B** Paracétamolémie à 4 h, antidote selon la courbe
- **C** Dosage immédiat pour décider
- **D** Naloxone i.v.
- **E** Flumazénil i.v.

Q54 **EX** **DX.8 vs DX.6 · liste complète** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 77 ans se sent mal et somnolent depuis 2 semaines. Il dit ne prendre « que ses comprimés pour la tension ». Bilan de base normal. PHQ-2 négatif.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Diagnostiquer une dépression masquée et traiter
- **B** Liste complète, y compris sans ordonnance
- **C** IRM cérébrale
- **D** Polysomnographie
- **E** Arrêter tous les antihypertenseurs

Q55 **EX** **DX.9 · rhinopharyngite** Prise en charge · cabinet

Un homme de 32 ans a depuis 2 jours de la fièvre à 38,2 °C, une rhinorrhée et un mal de gorge. Constantes normales, examen sans foyer bactérien. Il demande un antibiotique.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Amoxicilline 1 g trois fois par jour, 7 jours
- **B** Oseltamivir
- **C** Radiographie du thorax
- **D** Paracétamol et consignes écrites
- **E** Hémocultures

Q56 **EX** **DX.9 · grippe à risque** Prise en charge · cabinet

Une femme de 71 ans, BPCO, a depuis ce matin une fièvre brutale à 39 °C, des myalgies et une toux sèche, en pleine saison grippale. FR 18/min, PA 132/78 mmHg, SpO2 95 %.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Amoxicilline-clavulanate d'emblée
- **B** Paracétamol seul, sans test
- **C** Test grippe et oseltamivir 75 mg deux fois par jour
- **D** Oseltamivir après 72 heures si persistance
- **E** Hospitalisation en soins intensifs

Q57 **EX** **DX.9 vs DX.10 · fatigue après fièvre** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 45 ans a eu un syndrome grippal il y a 5 semaines. La fièvre a disparu, mais elle se sent toujours mal et fatiguée. Examen normal.

Quel bilan est le plus approprié ?

- **A** Sérologies virales étendues
- **B** TSH, glycémie, FSC, ferritine
- **C** Scanner thoraco-abdominal
- **D** Antibiotique d'épreuve
- **E** Aucun examen, convalescence sans limite

Q58 **EX** **DX.9 · retour des tropiques** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 38 ans rentre du Cameroun depuis 9 jours. Il a de la fièvre à 39 °C, des frissons et se sent très mal. Constantes stables, examen sans foyer.

Quel examen faut-il réaliser le jour même ?

- **A** Sérologies virales de contrôle à 3 semaines
- **B** Test grippe seul
- **C** Frottis et test rapide du paludisme
- **D** Radiographie du thorax seule
- **E** Aucun examen : virose probable

Q59 **EX** **DX.10 · anémie de l'homme** Prise en charge · cabinet

Un homme de 62 ans se sent mal et essoufflé à l'effort depuis 2 mois. Hb 98 g/L, VGM 72 fL, ferritine 9 µg/L, CRP normale. Pas de saignement visible.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Endoscopie digestive
- **B** Fer oral seul et contrôle à 3 mois
- **C** Transfusion de 2 concentrés
- **D** Vitamine B12 i.m.
- **E** Échographie pelvienne

Q60 **EX** **DX.10 · TSH modérée** Prise en charge · cabinet

Une femme de 36 ans se sent fatiguée. TSH 7 mU/L, fT4 normale. Pas de goitre. Elle n'a aucun autre symptôme.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Contrôle à 2–3 mois (anti-TPO, fT4)
- **B** Lévothyroxine 100 µg/j
- **C** Échographie thyroïdienne urgente avec Doppler
- **D** Scintigraphie thyroïdienne
- **E** Liothyronine

Q61 **AP** **DX.10 vs DX.4 · ferritine en inflammation** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 70 ans traitée pour une pneumonie a une anémie microcytaire (Hb 102 g/L). Ferritine 180 µg/L, CRP 95 mg/L.

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** Carence en fer exclue
- **B** Carence possible : doser la TSAT
- **C** Anémie hémolytique
- **D** Carence en vitamine B12
- **E** Fer i.v. d'emblée sans autre examen

Q62 **EX** **DX.11 · qSOFA à 1** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 83 ans se sent mal depuis hier. T 37,6 °C, FR 20/min, PA 118/70 mmHg, orienté mais lent. Il a un cathéter veineux depuis 5 jours.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Exclure le sepsis, car le qSOFA est inférieur à 2
- **B** Lactate et hémocultures
- **C** Retour à domicile avec paracétamol
- **D** Attendre la fièvre avant tout prélèvement
- **E** Procalcitonine seule pour décider

Q63 **EX** **DX.11 · PAM basse** Prise en charge · urgences

Une femme de 77 ans en choc septique d'origine urinaire a reçu 30 mL/kg de Ringer-lactate et de la ceftriaxone. PAM 58 mmHg, lactate 3,8 mmol/L.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Encore 3 L de cristalloïde
- **B** Dobutamine seule
- **C** Arrêter l'antibiotique en attendant la culture
- **D** Noradrénaline et soins intensifs
- **E** Corticoïde oral

Q64 **AP** **DX.11 vs DX.15 · choc réfractaire** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 70 ans, sous prednisone 10 mg/j depuis 2 ans, est en choc avec fièvre. Malgré remplissage et noradrénaline, la PA reste basse. Na 128, K 5,4 mmol/L.

Quel geste faut-il ajouter ?

- **A** Restriction hydrique
- **B** Arrêt de la noradrénaline
- **C** Test à la corticotropine avant décision
- **D** Fludrocortisone per os seule
- **E** Hydrocortisone 100 mg i.v.

Q65 **EX** **DX.12 · vertige continu** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 75 ans a depuis 5 heures un vertige continu, des vomissements et ne peut plus marcher. Nystagmus présent. Pas de déficit moteur. Glycémie normale. Le scanner sans contraste est normal.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Diagnostic de névrite vestibulaire et retour à domicile
- **B** Antivertigineux et contrôle chez l'ORL
- **C** Test HINTS par un clinicien formé ou IRM
- **D** Manœuvre de repositionnement d'emblée
- **E** Conclure à l'absence d'AVC sur le scanner normal

Q66 **EX** **DX.12 · scanner normal** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 81 ans a depuis 2 heures une confusion et une chute avec faiblesse de la main gauche. Glycémie 5,8 mmol/L. Le scanner cérébral sans contraste est normal.

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** AVC exclu, chercher une cause métabolique
- **B** Hémorragie probable
- **C** Accès de panique
- **D** Infarctus possible malgré le scanner
- **E** Delirium sur infection urinaire

Q67 **EX** **DX.13 · ECG normal** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 60 ans se sent mal depuis 2 heures, avec une gêne thoracique qui persiste. Le premier ECG est normal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Exclure le SCA sur l'ECG normal
- **B** Test d'effort immédiat
- **C** Retour à domicile et contrôle chez le médecin demain
- **D** ECG répété avec V7–V9, troponine 0/1 h
- **E** Coronarographie immédiate

Q68 **EX** **DX.13 vs DX.11 · troponine isolée** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 84 ans est hospitalisé pour un sepsis pulmonaire. Il n'a aucune douleur. Troponine hs élevée, stable sur deux dosages. ECG sans modification ischémique.

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** Infarctus de type 1 à traiter par coronarographie
- **B** STEMI
- **C** Erreur de laboratoire à ignorer
- **D** Dissection aortique
- **E** Lésion myocardique sans preuve d'infarctus

Q69 **EX** **DX.14 · adénopathie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 66 ans se sent mal depuis 2 mois. Il a perdu 7 kg et transpire la nuit. Ganglion sus-claviculaire gauche dur, fixe, de 2 cm. ACE élevé.

Quel examen pose le diagnostic ?

- **A** Répétition de l'ACE à 1 mois
- **B** Scanner seul
- **C** TEP-scanner seul
- **D** Biopsie avec histologie
- **E** Ponction-aspiration cytologique de contrôle à 3 mois

Q70 **EX** **DX.14 · syndrome constitutionnel** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 71 ans se sent mal depuis 3 mois. Elle a perdu 6 kg, n'a plus d'appétit. Hb 104 g/L sans cause trouvée. Examen sans masse ni adénopathie.

Quel examen est le plus approprié ?

- **A** Panel étendu de marqueurs tumoraux sériques
- **B** Réévaluation dans 6 mois
- **C** Scintigraphie osseuse
- **D** PHQ-9 seul
- **E** TDM thoraco-abdomino-pelvienne

Q71 **EX** **DX.15 · soluté** Prise en charge · urgences

Une femme de 45 ans, suivie pour maladie d'Addison, vomit depuis 24 heures. PA 82/50 mmHg, Na 124 mmol/L. Elle vient de recevoir 100 mg d'hydrocortisone i.v.

Quel soluté est le plus approprié ?

- **A** Glucose 5 % seul
- **B** NaCl 3 % en bolus
- **C** Restriction hydrique à 500 mL par jour
- **D** NaCl 0,9 % 1 L en 1 heure
- **E** Albumine 20 %

Q72 **EX** **DX.15 · substitué qui vomit** Prise en charge · domicile

Un homme de 52 ans, substitué par hydrocortisone pour une insuffisance surrénalienne primaire, a une gastro-entérite. Il vomit chaque prise depuis ce matin et se sent de plus en plus faible.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Doubler la dose orale
- **B** Suspendre l'hydrocortisone jusqu'à la fin des vomissements
- **C** Hydrocortisone par voie parentérale
- **D** Ajouter de la fludrocortisone seule
- **E** Antiémétique et attendre 24 heures

Q73 **EX** **DX.15 vs DX.2 · hyponatrémie trompeuse** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 58 ans se sent mal et a perdu 4 kg. PA 96/60 mmHg couchée, 78/50 debout. Na 129, K 5,6 mmol/L. Pigmentation des plis palmaires et des gencives. On évoque un SIADH.

Quel diagnostic faut-il évoquer en priorité ?

- **A** Insuffisance surrénalienne primaire
- **B** SIADH
- **C** Hyponatrémie induite par un thiazide
- **D** Hypothyroïdie
- **E** Potomanie avec apport hydrique excessif

Q74 **SPE · Rhumatologie** **DX.5 · dose de prednisone** Prise en charge · policlinique

Une femme de 74 ans a une polymyalgie rhumatismale confirmée. Infection et cancer ont été exclus. Elle n'a ni céphalée, ni trouble visuel, ni claudication de la mâchoire.

Quelle dose initiale de prednisone est la plus appropriée ?

- **A** 40 à 60 mg par jour
- **B** 5 mg par jour
- **C** 15 à 25 mg par jour
- **D** Bolus de 1 g de méthylprednisolone
- **E** Aucun corticoïde, AINS seuls

Q75 **SPE · Psychogériatrie** **DX.6 · escitalopram âgé** Prise en charge · cabinet

Un homme de 78 ans a une dépression confirmée. Son ECG ne montre pas d'allongement du QT. On choisit l'escitalopram.

Quelle dose maximale est la plus appropriée ?

- **A** 20 mg par jour
- **B** 40 mg par jour
- **C** 5 mg une fois par semaine
- **D** Même dose que l'adulte jeune, sans limite
- **E** 10 mg par jour

Q76 **SPE · Infectiologie** **DX.9 · mononucléose précoce** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une étudiante de 19 ans a depuis 4 jours une fièvre, une angine et des adénopathies cervicales postérieures. Rate palpable. Le test hétérophile est négatif.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Exclure la mononucléose
- **B** Amoxicilline pour angine bactérienne
- **C** Corticoïde systématique
- **D** Répéter le test ou sérologie VCA
- **E** Reprise du sport de contact

Q77 **SPE · Infectiologie** **DX.3 · légionellose** Prise en charge · hôpital

Un homme de 57 ans, fumeur, revient d'un hôtel. Pneumonie bilatérale, confusion, hyponatrémie, CRB-65 à 2. L'antigène urinaire de légionelle est négatif.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Exclure la légionellose
- **B** Amoxicilline seule à domicile
- **C** Bêta-lactamine plus macrolide
- **D** Oseltamivir seul
- **E** Pas d'antibiotique avant la culture

🚩 Pièges & alarmes · 17 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

Bactériurie asymptomatique, qSOFA rassurant à tort, cortisol « normal » en choc, correction trop rapide du sodium, nitrés et PDE5, Ringer et zolédronate, HbA1c faussée, flumazénil.

Q78 **EX** **DX.1 · bactériurie asymptomatique** Prise en charge · EMS

Une résidente d'EMS de 86 ans est confuse depuis 2 jours. Pas de brûlure, pas de fièvre, pas de douleur lombaire. Constantes stables. La bandelette urinaire montre leucocytes et nitrites positifs.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Fosfomycine 3 g en dose unique
- **B** Ceftriaxone i.v. pour un urosepsis présumé
- **C** ECBU de contrôle chaque semaine jusqu'à négativation
- **D** Chercher une autre cause, sans antibiotique
- **E** Sonde urinaire à demeure

Q79 **AP** **DX.1 · nitrofurantoïne et rein** Prise en charge · cabinet

Une femme de 76 ans a une cystite simple. DFGe 40 mL/min. Elle est allergique à la fosfomycine. On envisage la nitrofurantoïne.

Quelle est la conduite la plus appropriée pour la nitrofurantoïne ?

- **A** La prescrire à dose habituelle
- **B** La prescrire à demi-dose
- **C** Ne pas la prescrire à ce DFGe
- **D** La prescrire si la culture est sensible
- **E** La prescrire en dose unique

Q80 **AP** **DX.2 · perfusion de potassium** Prise en charge · hôpital

Un homme de 71 ans, après une diarrhée, se sent faible. K 2,9 mmol/L, créatinine normale. On prescrit du chlorure de potassium i.v.

Quelle modalité est la plus appropriée ?

- **A** Bolus i.v. direct de 20 mmol en 5 minutes
- **B** Dilué, au plus 10 mmol/h, sous ECG
- **C** 40 mmol/h par voie périphérique
- **D** Sans surveillance ECG
- **E** Concentré non dilué en seringue

Q81 **SPE · Néphrologie** **DX.2 · tolvaptan** Prise en charge · hôpital **question négative**

Une femme de 79 ans a vomi pendant 3 jours. Muqueuses sèches, hypotension orthostatique. Na 127 mmol/L, sans symptôme neurologique.

Quelle mesure est contre-indiquée ?

- **A** Soluté isotonique
- **B** Mesure de l'osmolalité et de la natriurèse
- **C** Arrêt d'un éventuel thiazide
- **D** Tolvaptan
- **E** Contrôle répété de la natrémie

Q82 **AP** **DX.13 · sildénafil** Prise en charge · urgences **question négative**

Un homme de 64 ans se sent mal avec une oppression thoracique. ECG : sous-décalage ST. Il a pris du sildénafil il y a 6 heures. PA 128/78 mmHg.

Quel médicament est contre-indiqué chez lui ?

- **A** Acide acétylsalicylique
- **B** Nitroglycérine
- **C** Énoxaparine
- **D** Oxygène si SpO2 < 90 %
- **E** Atorvastatine

Q83 **AP** **DX.13 · oxygène** Prise en charge · urgences

Une femme de 74 ans a un NSTEMI. Elle n'est pas dyspnéique. SpO2 96 % à l'air ambiant.

Quelle conduite pour l'oxygène est la plus appropriée ?

- **A** Pas d'oxygène
- **B** Oxygène 6 L/min systématique
- **C** Masque à haute concentration
- **D** Oxygène pour une SpO2 cible de 100 %
- **E** Ventilation non invasive

Q84 **AP** **DX.12 · AVK et thrombolyse** Prise en charge · urgences

Un homme de 73 ans sous acénocoumarol a une hémiparésie depuis 90 minutes. Scanner sans hémorragie. INR 1,6. Plaquettes 210 G/L. PA 170/95 mmHg.

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** Altéplase possible, l'INR est sous 2
- **B** Baisser d'abord la PA sous 140/90 mmHg
- **C** Altéplase après une dose de vitamine K
- **D** Altéplase contre-indiquée par l'INR
- **E** Plaquettes insuffisantes

Q85 **AP** **DX.14 · zolédronate et Ringer** Prise en charge · hôpital

Une femme de 70 ans a une hypercalcémie maligne (calcémie corrigée 3,3 mmol/L). Elle est hydratée par Ringer-lactate. On prescrit 4 mg de zolédronate.

Quelle modalité de perfusion est la plus appropriée ?

- **A** Dans la même poche de Ringer-lactate
- **B** En bolus i.v. de 1 minute
- **C** Par voie sous-cutanée
- **D** Avant toute hydratation
- **E** Voie séparée, NaCl 0,9 %, ≥ 15 min

Q86 **SPE · Endocrinologie** **DX.10 vs DX.15 · thyroïde et surrénale** Prise en charge · hôpital

Une femme de 51 ans a une hypothyroïdie manifeste (TSH 38 mU/L, fT4 basse). Elle a aussi une hypotension, une hyponatrémie et un cortisol du matin bas avec ACTH élevée.

Quel est l'ordre de traitement le plus approprié ?

- **A** Lévothyroxine d'abord
- **B** Les deux à pleine dose le même jour
- **C** Hydrocortisone d'abord, puis lévothyroxine
- **D** Lévothyroxine seule, car la TSH est très élevée
- **E** Fludrocortisone seule

Q87 **AP** **DX.10 · HbA1c et anémie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 67 ans se sent mal et urine beaucoup. Hb 84 g/L. HbA1c 5,4 %. Glycémies capillaires répétées à 14–17 mmol/L.

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** HbA1c faussée : se fier aux glycémies
- **B** Diabète exclu, car l'HbA1c est normale
- **C** Hypercalcémie seule en cause
- **D** Erreur de glucomètre
- **E** Potomanie

Q88 **AP** **DX.15 · cortisol normal en choc** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 62 ans, sous prednisone au long cours arrêtée il y a 1 semaine, est en choc. Son cortisol plasmatique aléatoire revient « dans la norme du laboratoire ».

Quelle est l'interprétation la plus appropriée ?

- **A** Crise exclue, arrêter l'hydrocortisone
- **B** Diagnostic de choc septique certain
- **C** Crise non exclue : on poursuit
- **D** Répéter le dosage avant tout traitement
- **E** Test à la corticotropine immédiat en choc

Q89 **SPE · Toxicologie clinique** **DX.8 · flumazénil et épilepsie** Prise en charge · urgences

Une femme de 45 ans, épileptique traitée au long cours par clonazépam, est somnolente après une prise excessive. FR 12/min, SpO2 95 %.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Flumazénil 0,3 mg i.v.
- **B** Naloxone 2 mg
- **C** Intubation orotrachéale immédiate
- **D** Acétylcystéine
- **E** Soutien et surveillance

Q90 **AP** **DX.8 · syndrome sérotoninergique** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 70 ans sous sertraline a reçu du tramadol il y a 2 jours. Elle est agitée, en sueur, T 38,6 °C, FC 118/min, avec un clonus des membres inférieurs.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- **A** Sepsis urinaire
- **B** Surdosage en tramadol (opioïde)
- **C** Crise d'anxiété
- **D** Syndrome sérotoninergique
- **E** Hypoglycémie

Q91 **SPE · Oncologie** **DX.14 · lyse tumorale** Prise en charge · hôpital

Un homme de 46 ans avec un lymphome à forte charge tumorale a, 48 heures après le début de la chimiothérapie, une oligurie, K 6,1 mmol/L et une hyperuricémie.

Quelle mesure est la plus appropriée ?

- **A** Alcalinisation des urines
- **B** Hydratation et rasburicase
- **C** Restriction hydrique
- **D** Poursuivre sans changement
- **E** Allopurinol seul à forte dose

Q92 **SPE · Cardiologie** **DX.13 · dissection** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 69 ans se sent mal avec une douleur thoracique « déchirante » irradiant dans le dos. PA 168/90 mmHg au bras droit, 128/70 mmHg au gauche. ECG : sus-décalage discret en DIII.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Aspirine 300 mg et héparine
- **B** Angio-CT avant tout antithrombotique
- **C** Fibrinolyse dans les 10 minutes
- **D** Troponine à 1 heure et observation en box
- **E** Test d'effort

Q93 **SPE · Infectiologie** **DX.4 · matériel infecté** Prise en charge · hôpital

Une femme de 67 ans en hémodialyse par cathéter veineux central a une fièvre et des frissons au branchement. Les hémocultures poussent à Staphylococcus aureus. Antibiotique i.v. débuté.

Quelle mesure est indispensable ?

- **A** Retirer le cathéter
- **B** Verrou antibiotique en gardant le cathéter
- **C** Antibiothérapie orale de 5 jours
- **D** Arrêter l'antibiotique si la fièvre cède
- **E** Hémocultures à répéter avant de décider

Q94 AP **DX.6 · PHQ-9 chez le grand malade** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 73 ans, hospitalisée depuis 3 jours, se sent mal, mange peu et pleure. PHQ-9 = 17. On n'a pas encore les résultats du bilan biologique.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Débuter la sertraline sur le score
- **B** Rechercher d'abord une cause somatique
- **C** Conclure à une dépression réactionnelle
- **D** Avis psychiatrique avant le bilan
- **E** Répéter le PHQ-9 dans 3 mois

⇢ Algorithme condensé · si… alors…

Si…	Alors…
Choc, qSOFA ≥ 2, lactate > 2 mmol/L	DX.11 : hémocultures, antibiotique dans l'heure, cristalloïde 30 mL/kg, noradrénaline si PAM < 65
Déficit focal ou trouble de la parole	DX.12 : glycémie, 144, scanner, altéplase avant 4,5 h, thrombectomie si gros vaisseau
Douleur thoracique, dyspnée, ECG anormal	DX.13 : ECG en 10 min, troponine hs 0/1 h, aspirine
Hypotension réfractaire, Na bas, K haut, corticoïdes	DX.15 : hydrocortisone 100 mg i.v. sans attendre, NaCl 0,9 % 1 L
Na < 125 mmol/L avec symptômes	DX.2 : NaCl 3 % en bolus, ≤ 10 mmol/L le 1er jour
Perte de poids, adénopathie, sueurs, Ca ≥ 3,0	DX.14 : scanner, biopsie ; hydratation puis zolédronate
Glycémie < 4,0 ou > 11 mmol/L	DX.10 : glucose, ou cétones et gaz du sang
Symptômes urinaires, fièvre, douleur lombaire	DX.1 : culture ; fosfomycine (cystite), ceftriaxone (pyélonéphrite)
Toux, fièvre, opacité	DX.3 : CRB-65, amoxicilline ou hôpital
Autre foyer infectieux	DX.4 : traiter et contrôler la source

Médicament récent ou augmenté	DX.8 : arrêt ou substitution, natrémie
Humeur basse, PHQ-9 ≥ 10	DX.6 : risque suicidaire, entretien, psychothérapie, sertraline
Ceintures et CRP élevée	DX.5 : exclure infection et cancer, rhumatologie
Contexte épidémique, bilan normal	DX.9 : symptomatique, réévaluer à 48–72 h
Aucune orientation	DX.7 : évaluation gériatrique, suivi programmé

Source : Phase A · Algorithme discriminant et §10 Arbre décisionnel.

✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

Q1 **EX** **DX.7 · premier geste**

✅ **A — Constantes complètes et glycémie capillaire**

① **Pourquoi c'est juste** Une plainte non spécifique chez la personne âgée est une urgence présumée. En 10 minutes : température, FC, PA, FR, SpO2, conscience et glycémie capillaire. Ces mesures dépistent le choc, l'hypoxie et l'hypoglycémie avant toute hypothèse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Elle n'est indiquée qu'avec des symptômes urinaires ou sans autre source chez un patient fébrile.
- **C** L'humeur s'évalue après l'exclusion des urgences vitales.
- **D** Sans déficit focal, l'imagerie ne précède pas les constantes.
- **E** À Bâle, 59 % de ces patients ont une maladie grave dans les 30 jours.

③ **Perle** Mortalité à 30 jours 6 % à Bâle ; mortalité hospitalière OR 2,50 par rapport aux plaintes spécifiques.

④ **Source** Phase A §4 Démarche diagnostique · LOT_005 audité

Q2 **EX** **DX.11 · afébrile et confuse**

✅ **A — Hémocultures, lactate, antibiotique i.v. dans l'heure**

① **Pourquoi c'est juste** qSOFA = 3 (FR ≥ 22/min, conscience altérée, PAS ≤ 100 mmHg) : risque de mort élevé en cas d'infection (DX.11). On prélève lactate et hémocultures sans retarder l'antibiotique, donné dans l'heure, puis remplissage si hypoperfusion.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La fièvre manque souvent chez le sujet âgé ; l'absence de fièvre n'exclut pas le sepsis.
- **C** Aucun déficit focal ; la confusion compte ici comme critère qSOFA.
- **D** Avec qSOFA 3, l'antibiotique ne doit pas attendre l'identification du foyer.
- **E** Traiter le symptôme sans la cause retarde le traitement du sepsis.

③ **Perle** Chez les plaintes non spécifiques, l'antibiotique arrive plus tard (5 h 26 contre 3 h 56) : c'est ce retard qui tue.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_005 audité

Q3 **EX** **DX.12 · déficit brutal**

✅ **D** — Glycémie capillaire

① **Pourquoi c'est juste** Devant un déficit brutal, la glycémie capillaire vient en premier : l'hypoglycémie imite l'AVC et se corrige en minutes (DX.12). On note ensuite l'heure du dernier état normal, on appelle le 144 et on fait le scanner.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Indispensable, mais l'hypoglycémie se corrige d'abord, car elle simule un AVC.
- **B** Jamais avant l'imagerie, et la fenêtre de 4,5 heures est dépassée ici.
- **C** Il ne précède ni la glycémie ni l'imagerie.
- **E** Elle n'a aucune place dans un déficit focal brutal.

③ **Perle** L'heure retenue est celle du dernier état normal (ici 22 h), pas celle de la découverte.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_005 audité

Q4 **EX** **DX.12 · heure de référence**

✅ **E** — 23 h, dernier état normal connu

① **Pourquoi c'est juste** La fenêtre de thrombolyse (4,5 heures) se compte depuis le dernier état asymptomatique connu (DX.12). Au réveil, l'heure est inconnue : l'ESO propose l'IRM diffusion-FLAIR pour décider.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'heure de la découverte n'est pas l'heure du début.
- **B** Elle ne reflète pas la durée de l'ischémie.
- **C** Elle sert au délai porte-imagerie, non à la fenêtre thérapeutique.
- **D** Aucune convention de ce type : on retient le dernier état normal.

③ **Perle** Si l'heure est inconnue, l'IRM diffusion-FLAIR peut encore ouvrir la thrombolyse.

④ **Source** Phase B DX.12 §10 · LOT_005 audité

Q5 EX DX.13 · dyspnée du diabétique

✅ **E** — ECG 12 dérivations dans les 10 minutes

① **Pourquoi c'est juste** Chez le sujet âgé, la femme et le diabétique, le SCA se manifeste souvent par un malaise ou une dyspnée sans douleur (DX.13). L'ECG se fait dans les 10 minutes, puis la troponine hs à 0 et 1 heure.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Utile ensuite ; l'ECG passe avant devant un équivalent angineux.
- **B** Ils ne précèdent pas l'ECG et ne visent pas le SCA.
- **C** Examen différé, sans place en urgence.
- **D** Le délai est incompatible avec un SCA possible.

③ **Perle** La dyspnée peut être le seul équivalent angineux.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_005 audité

Q6 EX DX.15 · choc et corticoïdes

✅ **A** — Hydrocortisone 100 mg i.v. immédiatement

① **Pourquoi c'est juste** Arrêt brutal d'une corticothérapie de plus de 2 semaines, vomissements, hypotension réfractaire et hyponatrémie : crise surrénalienne (DX.15). On prélève cortisol et ACTH, puis hydrocortisone 100 mg i.v. sans attendre le résultat, NaCl 0,9 % 1 L en 1 heure, et 200 mg/24 h ensuite.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le test confirme plus tard ; en crise, on traite sans attendre.
- **C** Le choc par déficit en cortisol reste réfractaire sans hydrocortisone.
- **D** Hypovolémique et en choc, il a besoin de volume, pas de restriction.
- **E** La voie orale échoue chez un patient qui vomit.

③ **Perle** Le glucocorticoïde exogène freine l'axe après plus de 2 semaines : le stress ou l'arrêt déclenchent la crise.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_005 audité

Q7 **EX** **DX.2 · hyponatrémie et convulsion**

✅ **C** — Bolus de NaCl 3 % 100 à 150 mL en soins intensifs

① **Pourquoi c'est juste** Natrémie < 125 mmol/L avec vomissements, somnolence ou convulsions : risque d'œdème cérébral (DX.2, 🚩 E5). Bolus de NaCl hypertonique 3 % en soins intensifs, puis correction lente (≤ 10 mmol/L le premier jour) ; arrêt du thiazide.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Réservée à l'hyponatrémie chronique asymptomatique.
- **B** Le soluté isotonique ne corrige pas une hyponatrémie profonde symptomatique.
- **D** Il n'a pas sa place dans l'urgence neurologique et est contre-indiqué en hypovolémie.
- **E** Les symptômes sévères imposent de traiter d'abord.

③ **Perle** Les symptômes sévères ne retardent pas l'hypertonique ; la surcorrection expose à la démyélinisation osmotique.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge · LOT_005 audité

Q8 **EX** **DX.14 · lombalgie nocturne**

✅ **B** — IRM de tout le rachis en urgence

① **Pourquoi c'est juste** Chez un patient avec antécédent de cancer, une douleur rachidienne nocturne peut être le premier signe d'une compression médullaire (DX.14). On demande une IRM de tout le rachis en urgence, avant l'apparition d'un déficit.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle manque une épidurite débutante.
- **C** Le délai est incompatible avec une compression possible.
- **D** Un marqueur sert au suivi ; il ne localise pas une lésion épidurale.
- **E** Attendre le déficit fait perdre la marche.

③ **Perle** Douleur dorsale avec déficit ou trouble sphinctérien : IRM du rachis entier et dexaméthasone en urgence.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_005 audité

Q9 EX DX.11 · remplissage

✅ **D** — Cristalloïde équilibré ≥ 30 mL/kg en 3 h

① **Pourquoi c'est juste** Hypoperfusion (lactate > 2 mmol/L, PA basse) : au moins 30 mL/kg de cristalloïde, de préférence équilibré comme le Ringer-lactate, dans les 3 premières heures (DX.11), soit 2 100 mL pour 70 kg. Noradrénaline si la PAM reste < 65 mmHg.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le glucose apporte de l'eau libre, sans effet volémique durable.
- **B** Les cristalloïdes restent la première ligne.
- **C** Volume très insuffisant dans l'hypoperfusion.
- **E** Le remplissage précède le vasopresseur.

③ **Perle** Surviving Sepsis Campaign 2021 : remplissage et antibiotique avancent ensemble, sans s'attendre.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_005 audité

Q10 EX DX.13 · sus-décalage

✅ **B** — Reperfusion coronaire sans attendre la troponine

① **Pourquoi c'est juste** Sus-décalage ST dans deux dérivations contiguës : STEMI (DX.13). AAS et héparine, reperfusion par angioplastie en moins de 120 minutes ; à défaut, fibrinolyse dans les 10 minutes. La troponine ne doit jamais retarder la reperfusion.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un STEMI se traite sans attendre la troponine ; elle peut rester normale au début.
- **C** Elle n'a pas sa place en phase aiguë et retarde la reperfusion.
- **D** Chaque minute perdue détruit du myocarde.
- **E** Le sus-décalage territorial impose la reperfusion.

③ **Perle** Un premier dosage de troponine normal est attendu dans les premières heures d'un vrai STEMI.

④ **Source** Phase B DX.13 §13 · LOT_005 audité

Q11 EX DX.10 · décompensation diabétique

✅ **B** — Cétonémie et gaz du sang, puis perfusion

① **Pourquoi c'est juste** Vomissements, respiration profonde ou confusion chez un diabétique : cétones, gaz du sang et perfusion avant l'insuline (DX.10). Acidocétose : glycémie > 11 mmol/L, cétonémie ≥ 3 mmol/L, pH < 7,3.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une insuline lente n'a pas sa place dans l'acidocétose ; on utilise une rapide i.v.
- **C** Elle ne dit rien de la décompensation aiguë.
- **D** La perfusion et le potassium précèdent l'insuline.
- **E** Vomissements et respiration ample signent une urgence.

③ **Perle** Insuline rapide i.v. ensuite, sous contrôle de la glycémie et du potassium.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_005 audité

Q12 EX DX.6 · idées suicidaires

✅ **D** — Évaluation psychiatrique urgente le jour même

① **Pourquoi c'est juste** Idées suicidaires avec plan ou accès aux moyens : évaluation psychiatrique urgente ou hospitalisation (DX.6, nœud N0). Toute idée suicidaire se demande directement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Avec un plan précis, la sécurité passe avant le traitement.
- **B** Délai incompatible avec un risque imminent.
- **C** Le bilan somatique est déjà normal ; le risque suicidaire prime.
- **E** Laisser partir une patiente avec plan et moyens est dangereux.

③ **Perle** Demander directement les idées suicidaires ne provoque pas le passage à l'acte.

④ **Source** Phase B DX.6 §10 · LOT_005 audité

Q13 **EX** **DX.8 · bradypnée et myosis**

✅ **C** — Naloxone 0,4 à 2 mg i.v. et oxygène

① **Pourquoi c'est juste** Respiration lente et myosis : surdosage opioïde probable (DX.8). Naloxone 0,4 à 2 mg i.v., i.m. ou s.c., répétable toutes les 2 à 3 minutes, oxygène et surveillance ; retirer le patch.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il antagonise les benzodiazépines, pas les opioïdes.
- **B** Le tableau toxique se traite d'abord.
- **D** C'est l'antidote du paracétamol.
- **E** La glycémie est normale.

③ **Perle** Sans effet après 2 ou 3 injections, l'état n'est pas dû aux opioïdes seuls : chercher une autre cause.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_005 audité

Q14 **EX** **DX.1 · pyélonéphrite fébrile**

✅ **D** — Échographie pour exclure un obstacle

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre avec douleur lombaire : pyélonéphrite (DX.1). L'ECBU confirme le germe ; l'échographie exclut un obstacle, car une pyélonéphrite obstructive exige un drainage urgent.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans place dans la prise en charge aiguë.
- **B** Examen invasif sans indication ici.
- **C** Remplacée par l'échographie ; contraste inutile.
- **E** La fosfomycine traite la cystite, pas la pyélonéphrite.

③ **Perle** Pyélonéphrite avec obstacle = drainage urgent ; l'antibiotique seul ne suffit pas.

④ **Source** Phase B DX.1 §10 · LOT_005 audité

Q15 **EX** **DX.4 · raideur de nuque**

✅ **E** — Antibiotique sans attendre la ponction lombaire

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre, confusion et raideur de nuque : méningite à suspecter (DX.4). Antibiotique sans délai ; la ponction lombaire ne doit pas le retarder.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On ne retarde pas l'antibiotique pour la ponction.
- **B** L'imagerie ne doit pas retarder l'antibiothérapie.
- **C** Une méningite bactérienne évolue en quelques heures.
- **D** Une méningite bactérienne doit être couverte d'emblée.

③ **Perle** Chez le sujet âgé, l'arthrose cervicale simule la raideur et le delirium peut la précéder.

④ **Source** Phase B DX.4 §10 · LOT_005 audité

Q16 **EX** **DX.14 · hypercalcémie**

✅ **C** — Hydratation i.v.

① **Pourquoi c'est juste** Calcémie corrigée ≥ 3,0 mmol/L : hypercalcémie, souvent maligne (DX.14, 🚩 E6). On hydrate d'abord, puis zolédronate 4 mg en au moins 15 minutes dans une voie séparée, et on cherche le cancer (scanner thoraco-abdominal, biopsie).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS impose de contrôler l'état hydrique avant le bisphosphonate.
- **B** L'hypercalcémie empêche le rein de concentrer l'urine : le patient est déjà déshydraté.
- **D** Ils aggravent l'hypercalcémie.
- **E** La recherche du cancer suit la correction ; la confusion impose de traiter d'abord.

③ **Perle** Confusion avec polyurie : calcémie corrigée par l'albumine.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge · LOT_005 audité

Q17 EX DX.9 · virose d'exclusion

✅ **C** — Urgences : hémocultures et antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** Le syndrome viral banal est un diagnostic d'exclusion (DX.9). FR ≥ 22/min, PAS ≤ 100 mmHg et conscience altérée = qSOFA 3 : urgences, hémocultures, antibiotique sans délai.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le diagnostic viral ne se pose qu'après exclusion des drapeaux rouges.
- **B** qSOFA à 3 : on ne temporise pas.
- **D** Un test positif n'exclut pas une surinfection ou un sepsis.
- **E** La vaccination prévient, elle ne traite pas un patient instable.

③ **Perle** Piège d'examen : poser « virose » avant d'avoir exclu les drapeaux rouges.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_005 audité

Q18 AP DX.7 · comportement de maladie

✅ **E** — Cytokines relayées au cerveau par la microglie

① **Pourquoi c'est juste** Les macrophages libèrent IL-1, IL-6 et TNF ; ces cytokines atteignent le cerveau par le nerf vague et les cellules endothéliales, la microglie les relaie et déclenche le comportement de maladie : fatigue, anorexie, somnolence, retrait (DX.7, Phase A §3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il n'y a pas d'infection cérébrale ; le signal est humoral et nerveux.
- **B** Elle donne une confusion aiguë, pas un comportement de retrait.
- **C** C'est un mécanisme invoqué pour la dépression, non pour l'infection.
- **D** La patiente n'a pas de fièvre.

③ **Perle** La réserve du sujet âgé est réduite : une maladie aiguë se résume souvent à la plainte générale.

④ **Source** Phase A §3 Physiopathologie · LOT_005 audité

Q19 **AP** **DX.2 · correction trop rapide**

✅ **A** — Démyélinisation osmotique du tronc cérébral

① **Pourquoi c'est juste** Une élévation trop rapide de la natrémie lèse le tronc cérébral : démyélinisation osmotique, avec tétraparésie, dysarthrie et troubles de conscience (DX.2). Ici + 17 mmol/L en 24 heures, au-delà de la limite de 10 mmol/L le premier jour.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La natrémie a été corrigée, et trop vite.
- **C** Rien n'oriente vers une hémorragie ; la chronologie suit la correction.
- **D** Le tableau suit l'élévation rapide de la natrémie.
- **E** Pas de fièvre ni de raideur.

③ **Perle** Hausse > 10 mmol/L par 24 heures : arrêter et abaisser.

④ **Source** Phase A §3 Physiopathologie · LOT_005 audité

Q20 **AP** **DX.15 · pigmentation**

✅ **A** — Excès d'ACTH stimulant les mélanocytes

① **Pourquoi c'est juste** Dans l'insuffisance surrénalienne primaire, le cortisol bas lève le frein sur l'hypophyse : l'ACTH en excès stimule les mélanocytes (DX.15). L'aldostérone manque aussi : hyponatrémie, hyperkaliémie, hypotension.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il explique l'hyperkaliémie et l'hypovolémie, pas la pigmentation.
- **C** Le cortisol manque dans ce tableau.
- **D** Rien ne l'évoque.
- **E** Les gencives et les plis ne sont pas exposés au soleil.

③ **Perle** Pas d'hyperpigmentation dans la forme secondaire, notamment après des corticoïdes.

④ **Source** Phase A §7 Approche syndromique · LOT_005 audité

Q21 **AP** **DX.11 · définition Sepsis-3**

✅ **D** — Sepsis

① **Pourquoi c'est juste** Sepsis-3 (2016) : infection suspectée ou prouvée avec hausse du SOFA ≥ 2 points (DX.11). Ici coagulation et rein ajoutent chacun des points. Cette hausse s'associe à une mortalité hospitalière > 10 %.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une dysfonction d'organe nouvelle est présente.
- **B** Il exige un vasopresseur et un lactate > 2 mmol/L malgré le remplissage.
- **C** Le SIRS seul ne définit plus le sepsis.
- **E** Elle n'est ni nécessaire ni suffisante.

③ **Perle** La fièvre seule, le SIRS, un qSOFA < 2 ou une CRP élevée ne suffisent pas.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_005 audité

Q22 **AP** **DX.4 · pourquoi pas de fièvre**

✅ **C** — Réponse inflammatoire atténuée avec l'âge

① **Pourquoi c'est juste** Chez le sujet âgé, la réponse inflammatoire est atténuée : la fièvre peut manquer et la plainte reste isolée (DX.4). Les infections sont la catégorie de diagnostics la plus représentée dans les plaintes non spécifiques.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'absence de fièvre n'exclut pas l'infection.
- **B** Hypothèse sans argument.
- **D** Ce n'est pas l'explication habituelle.
- **E** La fièvre ne distingue pas le virus de la bactérie.

③ **Perle** 82 ans, se sent mal, pas de fièvre : l'infection n'est pas exclue.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_005 audité

Q23 **AP** **DX.9 · procalcitonine**

✅ **B** — Pas d'antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** Étude suisse de premier recours : PCT ≤ 0,1 µg/L antibiotique fortement déconseillé ; ≤ 0,25 déconseillé ; > 0,25 recommandé (DX.9). La stratégie réduit les prescriptions de 72 % sans nuire à l'évolution.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** PCT ≤ 0,1 µg/L : antibiotique fortement déconseillé.
- **C** Aucune indication.
- **D** Aucun signe de gravité.
- **E** La PCT très basse ne justifie aucun antibiotique.

③ **Perle** La PCT guide ; elle ne remplace pas la recherche des drapeaux rouges.

④ **Source** Phase B DX.9 §8 · LOT_005 audité

Q24 **AP** **DX.13 · infarctus de type 2**

✅ **D** — Déséquilibre apport-besoin (type 2)

① **Pourquoi c'est juste** 4e définition universelle : le type 2 relève d'un déséquilibre entre apport et besoins en oxygène, sans rupture de plaque, par exemple anémie sévère, tachyarythmie ou hypotension (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le contexte d'anémie aiguë sévère oriente vers un déséquilibre, sans rupture.
- **B** Aucun geste coronaire récent.
- **C** Le patient est vivant et la troponine est dosée.
- **E** Le contexte hémorragique explique l'ischémie.

③ **Perle** On traite d'abord la cause du déséquilibre (ici le saignement), pas une plaque.

④ **Source** Phase B DX.13 §8 · LOT_005 audité

Q25 AP DX.6 · délai de l'antidépresseur

✅ **C** — Effet attendu en 2 à 4 semaines

① **Pourquoi c'est juste** La sertraline agit en 2 à 4 semaines (DX.6). Paliers de 50 mg par semaine, maximum 200 mg ; poursuite au moins 6 mois après la rémission. Réévaluer le PHQ-9 à 2–4 semaines.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le délai d'action n'est pas encore écoulé.
- **B** Un arrêt brutal est à éviter.
- **D** Les paliers sont d'au plus 50 mg par semaine.
- **E** Elle ne traite pas la dépression.

③ **Perle** Pas de baisse du PHQ-9 à 2–4 semaines : changer de stratégie.

④ **Source** Phase B DX.6 §13 · LOT_005 audité

Q26 SPE · Médecine intensive DX.11 · choc septique

✅ **E** — Choc septique

① **Pourquoi c'est juste** Choc septique (Sepsis-3) : vasopresseur nécessaire pour une PAM ≥ 65 mmHg et lactate > 2 mmol/L malgré un remplissage adéquat (DX.11). Mortalité hospitalière > 40 %.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le vasopresseur et le lactate élevé malgré le remplissage définissent le choc.
- **B** Le remplissage adéquat n'a pas corrigé la pression.
- **C** Le contexte est infectieux.
- **D** Elle ne décrit pas la défaillance circulatoire.

③ **Perle** Contrôler la source (ici chirurgie) dès que possible ; réévaluer l'antibiotique à 48–72 heures.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_005 audité

Q27 **SPE · Neurologie** **DX.12 · occlusion de gros vaisseau**

✅ **E** — Thrombectomie et transfert immédiat

① **Pourquoi c'est juste** Occlusion d'un gros vaisseau : thrombectomie, même après thrombolyse, avec transfert immédiat (DX.12). Recommandée jusqu'à 6 heures (preuve élevée), puis de 6 à 24 heures selon les critères des essais.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La thrombectomie s'ajoute à la thrombolyse.
- **B** Ni aspirine ni anticoagulant parentéral dans les 24 heures suivant la thrombolyse.
- **C** Elle ne traite pas l'occlusion.
- **D** Contre-indiquée après thrombolyse.

③ **Perle** Pas d'aspirine ni d'anticoagulant parentéral dans les 24 heures après altéplase.

④ **Source** Phase B DX.12 §10 · LOT_005 audité

Q28 **SPE · Endocrinologie** **DX.15 · confirmer le diagnostic**

✅ **B** — Test à la corticotropine 250 µg

① **Pourquoi c'est juste** Le test à la corticotropine de 250 µg est l'examen de référence (Endocrine Society 2016) (DX.15). Cortisol à 30 minutes > 500 nmol/L : fonction normale ; < 500 nmol/L : insuffisance. ACTH élevée : forme primaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un cortisol isolé ne conclut pas.
- **C** Elles orientent sans prouver.
- **D** Il cherche la cause une fois le diagnostic posé.
- **E** Ils concernent la thyroïde.

③ **Perle** Forme primaire : hydrocortisone et fludrocortisone ; forme centrale : hydrocortisone seule.

④ **Source** Phase B DX.15 §8 · LOT_005 audité

Q29 **SPE · Cardiologie** **DX.13 · score GRACE**

✅ **A** — Sous 24 heures

① **Pourquoi c'est juste** NSTE-ACS à haut risque (infarctus confirmé, ST dynamique ou GRACE > 140) : coronarographie sous 24 heures ; très haut risque : sous 2 heures (DX.13, ESC 2023).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Réservé au très haut risque : choc, douleur réfractaire, arythmie, œdème.
- **C** Un GRACE > 140 impose un délai court.
- **D** L'infarctus confirmé relève d'une stratégie invasive.
- **E** Le test d'effort n'a pas sa place dans un NSTEMI confirmé.

③ **Perle** GRACE : âge, FC, PA, créatinine, Killip, arrêt cardiaque, ST, troponine.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_005 audité

Q30 **SPE · Gériatrie** **DX.7 · confusion fluctuante**

✅ **C** — CAM, puis cause du delirium

① **Pourquoi c'est juste** CAM : début aigu, fluctuation, inattention, avec pensée désorganisée ou conscience altérée (sensibilité 94–100 %, spécificité 90–95 %) (DX.7). Delirium : chercher infection, trouble ionique, médicament, rétention urinaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le début aigu et la fluctuation orientent vers un delirium.
- **B** Le delirium hypoactif imite l'apathie dépressive.
- **D** Le traitement vise d'abord la cause.
- **E** Sans signe focal, on cherche d'abord les causes fréquentes.

③ **Perle** Le delirium hypoactif passe inaperçu ; il précède souvent la fièvre.

④ **Source** Phase A §6 Examen physique · LOT_005 audité

Q31 **SPE · Oncologie** **DX.14 · neutropénie fébrile**

✅ **E** — Hémocultures et antibiotique dans l'heure

① **Pourquoi c'est juste** Neutropénie fébrile (ESMO 2016) : PNN < 0,5 G/L et T > 38,5 °C, ou > 38,0 °C à deux reprises sur 2 heures (DX.14). Antibiotique à large spectre dans l'heure, sans attendre les résultats.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On ne retarde pas l'antibiotique.
- **B** La neutropénie fébrile évolue en quelques heures.
- **C** L'antibiotique ne doit pas attendre le foyer.
- **D** Il ne remplace pas l'antibiotique.

③ **Perle** Fièvre sous chimiothérapie : neutropénie fébrile jusqu'à preuve du contraire.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_005 audité

Q32 **EX** **DX.1 · cystite simple**

✅ **A** — Fosfomycine 3 g per os en dose unique

① **Pourquoi c'est juste** Cystite non compliquée de la femme non enceinte de moins de 65 ans : dysurie, pollakiurie et douleur sus-pubienne suffisent, sans test (SSGO 2020) (DX.1). Monuril® 3 g en dose unique, à jeun, le soir, vessie vidée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Chez la femme de moins de 65 ans avec ce tableau, aucun test n'est nécessaire.
- **C** Réservée à la pyélonéphrite ou à l'infection sévère.
- **D** Aucun signe de pyélonéphrite ni d'obstacle.
- **E** Elle ne fait pas partie du traitement court de la cystite non compliquée.

③ **Perle** Fosfomycine : femmes et adolescentes de plus de 12 ans ; pas chez l'homme.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_005 audité

Q33 **EX** **DX.1 · homme fébrile**

✅ **C** — ECBU, puis traitement d'une infection compliquée

① **Pourquoi c'est juste** Chez l'homme, l'infection urinaire se traite comme compliquée (DX.1) : ECBU d'abord, puis traitement plus long, adapté à la culture. Il en va de même en cas de grossesse, de sonde ou de comorbidité.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS limite l'indication curative à la femme et à l'adolescente.
- **B** Fièvre et symptômes chez l'homme imposent un traitement.
- **D** Chez l'homme, l'infection est toujours compliquée.
- **E** Le patient fébrile se traite dès l'ECBU prélevé.

③ **Perle** Monuril® n'est pas une option chez l'homme.

④ **Source** Phase B DX.1 §13 · LOT_005 audité

Q34 **EX** **DX.1 vs DX.11 · urosepsis**

✅ **A** — Prélèvements, puis antibiotique i.v. immédiat

① **Pourquoi c'est juste** Instabilité hémodynamique, confusion aiguë ou qSOFA ≥ 2 avec foyer urinaire : urosepsis (DX.1, DX.11). On prélève (hémocultures, ECBU), puis antibiotique i.v. immédiat, par exemple ceftriaxone, et remplissage.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le traitement oral court ne s'applique pas à un urosepsis.
- **C** L'antibiotique ne doit pas attendre la culture.
- **D** La confusion est ici un critère de sepsis, non un signe focal.
- **E** Instabilité et confusion imposent une prise en charge immédiate.

③ **Perle** Un signe de sepsis impose l'antibiotique i.v. immédiat après les prélèvements.

④ **Source** Phase B DX.1 §10 · LOT_005 audité

Q35 **EX** **DX.2 · hyponatrémie modérée**

✅ **E** — Osmolalité, natriurèse et évaluation de la volémie

① **Pourquoi c'est juste** Une natrémie basse seule ne donne pas la cause (DX.2) : on mesure l'osmolalité plasmatique et urinaire, la natriurèse et la volémie. On cherche thiazide, ISRS, insuffisance surrénalienne, SIADH.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Réservé aux symptômes sévères ou à la natrémie profonde symptomatique.
- **B** Contre-indiqué en cas d'hypovolémie, à exclure d'abord.
- **C** Aucun signe neurologique focal.
- **D** Une hyponatrémie modérée explique faiblesse et nausées.

③ **Perle** Thiazide et antidépresseur ensemble : contrôler la natrémie, surtout chez la personne âgée.

④ **Source** Phase B DX.2 §10 · LOT_005 audité

Q36 **EX** **DX.2 · hyperkaliémie et ECG**

✅ **B** — Calcium i.v. immédiat

① **Pourquoi c'est juste** Hyperkaliémie avec modification ECG : calcium i.v. immédiat (DX.2), ECG en continu, puis traitement selon le protocole local ; évoquer une crise surrénalienne si le contexte s'y prête.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il aggrave l'hyperkaliémie.
- **C** Mesure de fond, inefficace en urgence.
- **D** Le délai est incompatible avec un QRS large.
- **E** Avec un ECG anormal, on traite d'abord.

③ **Perle** Un prélèvement hémolysé augmente faussement le potassium : vérifier avant de conclure sans ECG anormal.

④ **Source** Phase B DX.2 §13 · LOT_005 audité

Q37 **AP** **DX.2 vs DX.14 · calcémie à corriger**

✅ **D** — Calculer la calcémie corrigée par l'albumine

① **Pourquoi c'est juste** Une calcémie brute sans albumine peut tromper (DX.2) : il faut la corriger par l'albumine avant de conclure. L'hypercalcémie maligne se définit par une calcémie corrigée ≥ 3,0 mmol/L.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La calcémie brute est faussement basse quand l'albumine est basse.
- **B** La valeur brute est basse ; seule la valeur corrigée tranche.
- **C** Il vient après la calcémie corrigée.
- **E** On ne conclut pas sans corriger par l'albumine.

③ **Perle** Corriger la calcémie par l'albumine avant toute décision.

④ **Source** Phase B DX.2 §8 · LOT_005 audité

Q38 **EX** **DX.3 · CRB-65**

✅ **A** — Hospitalisation urgente, soins intensifs à discuter

① **Pourquoi c'est juste** CRB-65 : confusion, FR ≥ 30/min, PAS < 90 ou PAD ≤ 60 mmHg, âge ≥ 65 ans (DX.3). Score 4 : hospitalisation urgente, soins intensifs à discuter, hémocultures, bêta-lactamine i.v.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** CRB-65 à 4 : le domicile est exclu.
- **C** La gravité impose une décision immédiate.
- **D** Cette option vaut pour un score de 1 à 2.
- **E** La CRP seule ne décide pas du lieu de soins.

③ **Perle** Score 0 : domicile si le contexte le permet ; 1 à 2 : hospitalisation à envisager ; 3 à 4 : urgence.

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_005 audité

Q39 EX DX.3 · pneumonie simple

✅ **D** — Amoxicilline per os à domicile

① **Pourquoi c'est juste** CRB-65 à 0 et contexte stable : traitement ambulatoire par amoxicilline (DX.3). Le macrolide s'ajoute en cas de gravité ou de légionellose. Fièvre persistante après 72 heures : chercher un empyème ou un autre diagnostic.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** CRB-65 à 0 : l'hospitalisation n'est pas nécessaire.
- **B** Un infiltrat nouveau avec signes infectieux pose le diagnostic de pneumonie.
- **C** Rien n'oriente vers une grippe.
- **E** Le macrolide s'ajoute en cas de gravité ou de légionellose.

③ **Perle** Dose AIPS dans l'infection légère à moyenne : 1 500 à 3 000 mg par jour en 3 à 4 prises.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_005 audité

Q40 EX DX.3 · radiographie normale

✅ **E** — Échographie pulmonaire ou scanner thoracique

① **Pourquoi c'est juste** Une radiographie normale au début n'exclut pas la pneumonie (DX.3). Si la suspicion est forte, l'échographie ou le scanner tranche. Chez le sujet âgé, chute, confusion ou asthénie peuvent être la seule présentation.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une radiographie précoce normale n'exclut pas la pneumonie.
- **B** Le délai est inadapté à une infection aiguë.
- **C** Examen invasif, non indiqué en première intention.
- **D** Elle sert surtout à arrêter l'antibiotique.

③ **Perle** La pneumonie du sujet âgé peut être silencieuse à l'auscultation comme à la radiographie.

④ **Source** Phase B DX.3 §10 · LOT_005 audité

Q41 **EX** **DX.4 · abcès**

✅ **E** — Drainage de l'abcès

① **Pourquoi c'est juste** L'antibiotique seul échoue sur une collection : il faut drainer le pus ou retirer le matériel infecté (DX.4). Le contrôle de la source fait partie du traitement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un abcès ne guérit pas par l'antibiotique seul.
- **B** Le foyer reste actif et non contrôlé.
- **C** Rien n'oriente vers un champignon.
- **D** Ils masquent l'infection sans la traiter.

③ **Perle** Abcès = drainage ; matériel infecté = retrait.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_005 audité

Q42 **EX** **DX.4 · douleur disproportionnée**

✅ **B** — Avis chirurgical urgent

① **Pourquoi c'est juste** Une douleur cutanée disproportionnée chez un patient fébrile impose d'appeler le chirurgien (DX.4). On traite comme un sepsis si la pression baisse : hémocultures, antibiotique dans l'heure.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La douleur disproportionnée évoque une infection nécrosante.
- **C** Le tableau infectieux prime sur la thrombose.
- **D** Ils masquent l'évolution.
- **E** Délai incompatible avec une infection nécrosante.

③ **Perle** Chercher le foyer partout : poumon, voie urinaire, peau, abdomen, cœur, cathéter.

④ **Source** Phase B DX.4 §10 · LOT_005 audité

Q43 **EX** **DX.4 · pas de foyer**

✅ **A** — Scanner, puis cause non infectieuse

① **Pourquoi c'est juste** Si aucun foyer n'apparaît après le bilan, on fait un scanner, puis on cherche une cause non infectieuse (DX.4) : inflammatoire, néoplasique, médicamenteuse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Sans foyer ni gravité, elle masque le diagnostic.
- **C** La recherche n'est pas terminée.
- **D** Fièvre sans foyer = recherche à poursuivre.
- **E** Il n'apporte rien de nouveau.

③ **Perle** Piège : arrêter la recherche après une première infection trouvée, ou conclure trop tôt.

④ **Source** Phase B DX.4 §10 · LOT_005 audité

Q44 **EX** **DX.5 · ceintures**

✅ **C** — Polymyalgie rhumatismale

① **Pourquoi c'est juste** Après 50 ans, douleur bilatérale des épaules, raideur matinale > 45 minutes et CRP élevée évoquent une polymyalgie rhumatismale (DX.5). Il faut d'abord exclure infection et cancer, chercher une artérite à cellules géantes, puis demander l'avis de rhumatologie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle ne donne ni raideur matinale prolongée ni CRP élevée.
- **B** FR et ACPA négatifs, pas de synovite des petites articulations.
- **D** Elle donne une faiblesse avec CK élevée, sans raideur des ceintures.
- **E** La CRP élevée et la raideur orientent vers l'inflammation.

③ **Perle** Les critères EULAR/ACR 2012 classent, ils ne posent pas le diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_005 audité

Q45 EX DX.5 🚩 · trouble visuel

✅ **E** — Glucocorticoïde immédiat et avis spécialisé sous 24 h

① **Pourquoi c'est juste** Trouble visuel, claudication de la mâchoire et céphalée temporale : artérite à cellules géantes (DX.5). Glucocorticoïde sans attendre la biopsie et avis spécialisé sous 24 heures, car la cécité est irréversible.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Attendre la biopsie expose à une cécité irréversible.
- **B** Délai incompatible avec la menace visuelle.
- **C** Elle ne doit pas retarder le traitement.
- **D** Dose de la polymyalgie, insuffisante pour l'artérite.

③ **Perle** Une biopsie normale n'exclut pas l'artérite.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_005 audité

Q46 EX DX.5 vs DX.8 · CK sous statine

✅ **B** — Arrêter la statine, contrôler CK et créatinine

① **Pourquoi c'est juste** Faiblesse proximale avec CK élevée sous médicament myotoxique : arrêter le médicament suspect, puis contrôler CK et créatinine, car la CK élevée peut annoncer une rhabdomyolyse (DX.5, DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La CK élevée sous médicament myotoxique peut annoncer une rhabdomyolyse.
- **C** La faiblesse avec CK élevée n'est pas une polymyalgie.
- **D** Elle aggraverait la myopathie.
- **E** L'arrêt de la cause suspecte vient d'abord.

③ **Perle** L'amélioration à l'arrêt est le meilleur test diagnostique d'un effet indésirable.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_005 audité

Q47 **EX** **DX.6 · PHQ-9 positif**

✅ **B** — Entretien clinique selon les critères DSM-5

① **Pourquoi c'est juste** PHQ-9 ≥ 10 avec bilan normal : entretien clinique pour poser le diagnostic (DX.6). DSM-5 : au moins 5 symptômes sur 9 pendant 2 semaines, dont humeur dépressive ou perte d'intérêt, avec détresse ou handicap.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le PHQ-9 est un outil de dépistage, pas un diagnostic.
- **C** Aucun signe d'appel de cancer.
- **D** Aucun argument pour une insuffisance surrénalienne.
- **E** Elle ne traite pas la dépression et expose à la dépendance.

③ **Perle** Méta-analyse 2019 : seuil 10, sensibilité 0,88, spécificité 0,85.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_005 audité

Q48 **EX** **DX.6 vs DX.13 · anxiété et thorax**

✅ **C** — ECG et troponine hs

① **Pourquoi c'est juste** L'anxiété ne doit jamais exclure un SCA, une infection ou une cause endocrinienne (DX.6, DX.13). L'ECG et la troponine précèdent tout diagnostic d'anxiété devant une douleur thoracique avec dyspnée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'anxiété ne s'attribue qu'après exclusion du SCA.
- **B** Attribution prématurée d'une douleur thoracique.
- **D** Le traitement de fond ne répond pas à une urgence possible.
- **E** Le bilan organique précède l'avis psychiatrique.

③ **Perle** Fièvre, confusion, déficit ou douleur thoracique : bilan organique urgent avant d'attribuer à l'anxiété.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_005 audité

Q49 **EX** **DX.7 · bilan de première intention**

✅ **A** — ECG, ionogramme, Ca, créatinine, glucose, FSC, CRP, TSH

① **Pourquoi c'est juste** Sans urgence vitale, on va du général au particulier (DX.7) : anamnèse et médicaments, examen complet, puis ECG, ionogramme, calcémie, créatinine, glucose, hémogramme, CRP et TSH. Les examens ciblés suivent les signes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Examens de deuxième intention, réservés à un signe d'appel.
- **C** Sans signe neurologique, ils ne sont pas de première intention.
- **D** Réservés à une suspicion d'insuffisance surrénalienne.
- **E** Marqueurs de recherche, non validés en routine.

③ **Perle** Un bilan de base normal n'exclut rien : réévaluer à 48–72 heures.

④ **Source** Phase A §4 Démarche diagnostique · LOT_005 audité

Q50 **EX** **DX.7 · bilan normal**

✅ **A** — Revoir à 48 h et à une semaine

① **Pourquoi c'est juste** La plupart des diagnostics tombent après la première consultation (DX.7) : on revoit le patient à 48 heures et à une semaine, et on envisage la dépression (DX.6) et les médicaments (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un bilan de base normal n'exclut pas une maladie.
- **C** Sans signe d'appel, il n'est pas de première intention.
- **D** Sans foyer ni gravité, il n'est pas indiqué.
- **E** Constantes stables et entourage présent permettent un suivi rapproché.

③ **Perle** Le diagnostic des urgences n'est correct que dans 46 % des cas.

④ **Source** Phase B DX.7 §10 · LOT_005 audité

Q51 **AP** **DX.7 · critères de sortie**

✅ **E** — Mobilité, cognition et médicaments revus

① **Pourquoi c'est juste** Critères de retour à domicile : constantes stables 24 heures, cause identifiée et traitée, boisson et alimentation suffisantes, mobilité et cognition évaluées, médicaments revus, entourage organisé, suivi à 48–72 heures (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle n'est pas un critère de sortie.
- **B** Le contrôle radiologique est différé.
- **C** Pas exigées pour la sortie.
- **D** Une toux peut persister plusieurs semaines.

③ **Perle** Consultation de suivi à 48–72 heures après la sortie.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge · LOT_005 audité

Q52 **EX** **DX.8 · thiazide et ISRS**

✅ **A** — Arrêter le thiazide et surveiller la natrémie

① **Pourquoi c'est juste** Malaise apparu après un changement de traitement : chronologie, natrémie, arrêt ou substitution avec le prescripteur (DX.8). Les thiazides provoquent ou aggravent l'hyponatrémie, surtout avec un antidépresseur.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Réservé aux symptômes sévères.
- **C** L'ISRS contribue lui aussi à l'hyponatrémie.
- **D** On ne traite pas un effet indésirable par un autre diurétique.
- **E** Un thiazide est incompatible avec une hyponatrémie symptomatique.

③ **Perle** 12,2 % des plaintes non spécifiques ont un problème médicamenteux ; 40 % seulement sont reconnus à l'accueil.

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_005 audité

Q53 **EX** **DX.8 · paracétamol**

✅ **B** — Paracétamolémie à 4 h, antidote selon la courbe

① **Pourquoi c'est juste** Un surdosage en paracétamol impose une prise en charge même sans symptôme (DX.8). Concentration plasmatique au moins 4 heures après la prise, puis acétylcystéine selon la courbe ; seuil toxique chez l'adulte 7,5 à 10 g.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'absence de symptôme ne protège pas.
- **C** Avant 4 heures, la concentration n'est pas interprétable.
- **D** Elle antagonise les opioïdes, pas le paracétamol.
- **E** Il antagonise les benzodiazépines.

③ **Perle** Concentration > 200 µg/mL à 4 h : toxique.

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_005 audité

Q54 **EX** **DX.8 vs DX.6 · liste complète**

✅ **B** — Liste complète, y compris sans ordonnance

① **Pourquoi c'est juste** Le médecin demande toujours la liste complète des médicaments, y compris sans ordonnance, avant de conclure à une cause non médicamenteuse (DX.8). Les critères STOPP/START repèrent les prescriptions inadaptées.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le PHQ-2 est négatif ; la piste médicamenteuse n'est pas explorée.
- **C** Sans signe focal, elle n'est pas la première étape.
- **D** Prématurée avant d'avoir revu les médicaments.
- **E** On arrête l'agent suspect identifié, pas tout le traitement.

③ **Perle** Reconstituer la chronologie des prises avec l'ordonnance.

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_005 audité

Q55 EX DX.9 · rhinopharyngite

✅ **D** — Paracétamol et consignes écrites

① **Pourquoi c'est juste** Sans drapeau rouge ni foyer, le syndrome viral se traite symptomatiquement (DX.9) : paracétamol 500 mg à 1 g par prise, au plus 4 g par jour, consigne écrite de reconsulter.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le virus ne répond pas à l'antibiotique.
- **B** Réservé à la grippe d'un patient à risque.
- **C** Aucun signe respiratoire bas.
- **E** Aucun drapeau rouge.

③ **Perle** Un antibiotique ne se prescrit pas sans foyer bactérien prouvé.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_005 audité

Q56 EX DX.9 · grippe à risque

✅ **C** — Test grippe et oseltamivir 75 mg deux fois par jour

① **Pourquoi c'est juste** Début brutal en saison grippale chez une patiente à risque : test et antiviral (DX.9). Oseltamivir 75 mg deux fois par jour pendant 5 jours, dès le jour des symptômes ou le lendemain, idéalement dans les 36 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Aucun foyer bactérien n'est établi.
- **B** Patiente à risque vue tôt : l'antiviral est indiqué.
- **D** Il se donne idéalement dans les 36 heures.
- **E** Constantes stables : pas d'indication.

③ **Perle** Clairance 30 à 60 mL/min : 30 mg deux fois par jour.

④ **Source** Phase B DX.9 §10 · LOT_005 audité

Q57 **EX** **DX.9 vs DX.10 · fatigue après fièvre**

✅ **B** — TSH, glycémie, FSC, ferritine

① **Pourquoi c'est juste** Une fatigue qui persiste après la fièvre impose de chercher une anémie, une hypothyroïdie ou un diabète (DX.9, DX.10) : TSH, glycémie, FSC, ferritine.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elles ne prouvent pas la cause de la fatigue.
- **C** Aucun signe d'appel de cancer.
- **D** Aucun foyer bactérien.
- **E** Une fatigue persistante après la fièvre impose une recherche ciblée.

③ **Perle** Si fièvre prolongée, amaigrissement ou sueurs nocturnes : bilan élargi (DX.14).

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_005 audité

Q58 **EX** **DX.9 · retour des tropiques**

✅ **C** — Frottis et test rapide du paludisme

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre au retour des tropiques : frottis et test rapide du paludisme le jour même (DX.9, arbre décisionnel). Le syndrome viral ne se pose qu'après exclusion des drapeaux rouges.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le paludisme ne s'exclut pas en différé.
- **B** Un retour de zone tropicale impose d'exclure le paludisme.
- **D** Aucun signe respiratoire.
- **E** Le diagnostic viral est d'exclusion.

③ **Perle** Le frottis se fait le jour même, jamais en différé.

④ **Source** Phase B DX.9 §10 · LOT_005 audité

Q59 EX DX.10 · anémie de l'homme

✅ **A** — Endoscopie digestive

① **Pourquoi c'est juste** Une anémie ferriprive inexpliquée chez l'homme ou la femme ménopausée impose une endoscopie digestive (DX.10) : un tiers ont une lésion. Le fer suit la recherche de la source.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il faut d'abord chercher la source digestive.
- **C** Anémie bien tolérée, sans signe de gravité.
- **D** L'anémie est microcytaire avec ferritine basse.
- **E** Elle ne cherche pas la source chez l'homme.

③ **Perle** Carence en fer : ferritine < 30 µg/L sans inflammation.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_005 audité

Q60 EX DX.10 · TSH modérée

✅ **A** — Contrôle à 2–3 mois (anti-TPO, fT4)

① **Pourquoi c'est juste** TSH 4,0 à 10 mU/L avec fT4 normale : hypothyroïdie subclinique, à confirmer à 2–3 mois avec anti-TPO et fT4 (ETA 2013) (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Dose d'entretien sans indication confirmée.
- **C** Aucun nodule ni goitre.
- **D** Sans place dans l'hypothyroïdie subclinique.
- **E** Pas de traitement sans confirmation.

③ **Perle** TSH ≥ 10 mU/L confirmée avant 70 ans : traiter.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_005 audité

Q61 **AP** **DX.10 vs DX.4 · ferritine en inflammation**

✅ **B** — Carence possible : doser la TSAT

① **Pourquoi c'est juste** La ferritine monte avec l'inflammation : une valeur normale n'exclut pas la carence en fer (DX.10). On associe CRP et saturation de la transferrine ; ferritine 30 à 50 µg/L avec TSAT < 20 % évoque la carence (consensus suisse 2019).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La ferritine monte avec l'inflammation.
- **C** Aucun argument pour l'hémolyse.
- **D** L'anémie est microcytaire.
- **E** Aucune carence n'est encore prouvée.

③ **Perle** Anémie microcytaire avec CRP et ferritine élevées : anémie inflammatoire probable, traiter la cause.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_005 audité

Q62 **EX** **DX.11 · qSOFA à 1**

✅ **B** — Lactate et hémocultures

① **Pourquoi c'est juste** Un qSOFA < 2 n'exclut pas le sepsis : c'est un outil de pronostic, non de dépistage (DX.11). On mesure toutes les constantes et le lactate ; on cherche le foyer, ici le cathéter.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le qSOFA est trop peu sensible pour exclure.
- **C** Un foyer possible chez un patient fragile impose une évaluation.
- **D** La fièvre peut manquer chez le sujet âgé.
- **E** Elle ne remplace ni le lactate ni le jugement clinique.

③ **Perle** La Surviving Sepsis Campaign déconseille le qSOFA comme outil unique de dépistage.

④ **Source** Phase B DX.11 §13 · LOT_005 audité

Q63 **EX** **DX.11 · PAM basse**

✅ **D** — Noradrénaline et soins intensifs

① **Pourquoi c'est juste** Si la PAM reste < 65 mmHg malgré le remplissage, noradrénaline en première ligne et soins intensifs (DX.11). Cible : PAM ≥ 65 mmHg.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le vasopresseur vient quand la PAM reste basse après le remplissage.
- **B** La noradrénaline est le vasopresseur de première ligne.
- **C** Aucune raison d'interrompre le traitement.
- **E** Pas de place ici en première ligne.

③ **Perle** AIPS : 8 à 12 µg/min au départ chez l'adulte de 70 kg.

④ **Source** Phase B DX.11 §13 · LOT_005 audité

Q64 **AP** **DX.11 vs DX.15 · choc réfractaire**

✅ **E** — Hydrocortisone 100 mg i.v.

① **Pourquoi c'est juste** Un choc réfractaire chez un patient sous glucocorticoïde au long cours fait suspecter une crise surrénalienne (DX.11, DX.15) : hydrocortisone 100 mg i.v. sans attendre le résultat.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le patient est en choc.
- **B** Elle reste nécessaire.
- **C** Le test confirme plus tard ; on ne retarde pas la dose.
- **D** Elle ne remplace pas le cortisol en urgence.

③ **Perle** Un déficit en cortisol évolue vers un choc réfractaire aux liquides.

④ **Source** Phase A §3 Physiopathologie · LOT_005 audité

Q65 EX DX.12 · vertige continu

✅ **C** — Test HINTS par un clinicien formé ou IRM

① **Pourquoi c'est juste** Un vertige continu avec nystagmus et marche impossible n'est pas une névrite avant le test HINTS ou l'IRM (DX.12). Impulsion normale, nystagmus changeant ou skew : cause centrale, IRM.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le tronc cérébral et le cervelet donnent ce tableau.
- **B** Le vertige central doit être exclu d'abord.
- **D** Elle vise un vertige positionnel bref, non un vertige continu.
- **E** Un scanner normal n'exclut pas un infarctus du tronc cérébral.

③ **Perle** HINTS : 100 % de sensibilité dans l'étude initiale, chez des cliniciens formés seulement.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_005 audité

Q66 EX DX.12 · scanner normal

✅ **D** — Infarctus possible malgré le scanner

① **Pourquoi c'est juste** Le scanner sans contraste distingue hémorragie et infarctus, mais un scanner normal à la phase aiguë n'exclut pas l'infarctus (DX.12). L'IRM de diffusion est plus sensible ; la décision de thrombolyse se prend dans la fenêtre de 4,5 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le scanner précoce ne montre pas l'infarctus récent.
- **B** Le scanner sans contraste exclut justement l'hémorragie.
- **C** Diagnostic d'exclusion, inadapté devant un déficit focal.
- **E** Un déficit focal ne s'explique pas par un delirium.

③ **Perle** AVC manqué dans 64 % des présentations non spécifiques contre 15,3 % en général.

④ **Source** Phase B DX.12 §8 · LOT_005 audité

Q67 **EX** **DX.13 · ECG normal**

✅ **D** — ECG répété avec V7–V9, troponine 0/1 h

① **Pourquoi c'est juste** Un ECG normal n'exclut pas un SCA (DX.13) : l'occlusion de la circonflexe est souvent silencieuse sur 12 dérivations. On répète l'ECG à 15–30 minutes, on ajoute V7–V9 et on dose la troponine hs à 0 et 1 heure.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un ECG normal n'exclut pas un SCA.
- **B** Contre-indiqué tant que le SCA n'est pas exclu.
- **C** La douleur persiste : le doute impose la surveillance.
- **E** Réservée au STEMI ou au très haut risque.

③ **Perle** La troponine hs à 0 et 1 heure tranche ; chaque test a ses propres seuils.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_005 audité

Q68 **EX** **DX.13 vs DX.11 · troponine isolée**

✅ **E** — Lésion myocardique sans preuve d'infarctus

① **Pourquoi c'est juste** L'infarctus exige une troponine > 99e percentile avec montée ou baisse et un contexte d'ischémie (4e définition universelle, 2018) (DX.13). Sepsis, insuffisance rénale, embolie et myocardite élèvent aussi la troponine.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une troponine élevée seule n'est pas un infarctus.
- **B** Pas de sus-décalage ST.
- **C** Une lésion myocardique se surveille ; elle n'est pas une erreur.
- **D** Rien n'oriente vers une dissection.

③ **Perle** Seul le profil dynamique avec contexte ischémique compte.

④ **Source** Phase B DX.13 §8 · LOT_005 audité

Q69 **EX** **DX.14 · adénopathie**

✅ **D** — Biopsie avec histologie

① **Pourquoi c'est juste** Le cancer se prouve par l'histologie, jamais par l'imagerie ou un marqueur seul (DX.14). Masse palpable ou adénopathie : biopsie. Un ganglion sus-claviculaire gauche peut signaler une tumeur abdominale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un marqueur sert au suivi, pas au diagnostic.
- **B** L'imagerie évoque, elle n'affirme pas.
- **C** Il oriente la biopsie mais ne prouve pas le cancer.
- **E** Le délai est inadapté et l'histologie prime.

③ **Perle** Imagerie et avis spécialisé sous 1 à 2 semaines devant perte de poids, adénopathie, sueurs nocturnes.

④ **Source** Phase B DX.14 §8 · LOT_005 audité

Q70 **EX** **DX.14 · syndrome constitutionnel**

✅ **E** — TDM thoraco-abdomino-pelvienne

① **Pourquoi c'est juste** Syndrome constitutionnel ou anémie sans cause : TDM thoraco-abdomino-pelvienne, puis biopsie du site accessible (DX.14). Si l'imagerie n'est pas conclusive : TEP et avis d'oncologie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ils ne posent pas le diagnostic.
- **B** Le délai est incompatible avec un cancer possible.
- **C** Pas d'orientation osseuse.
- **D** La dépression ne s'envisage qu'après exclusion de la cause organique.

③ **Perle** Un patient cancéreux sur dix reçoit son diagnostic aux urgences.

④ **Source** Phase B DX.14 §10 · LOT_005 audité

Q71 **EX** **DX.15 · soluté**

✅ **D** — NaCl 0,9 % 1 L en 1 heure

① **Pourquoi c'est juste** Crise surrénalienne : hydrocortisone 100 mg i.v., puis NaCl 0,9 % 1 L dans la première heure, puis selon les besoins (DX.15). Pas de soluté glucosé seul.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il apporte de l'eau libre et peut aggraver l'hyponatrémie.
- **B** Réservé à l'hyponatrémie profonde avec symptômes neurologiques.
- **C** Elle est en choc hypovolémique.
- **E** Le cristalloïde isotonique est la première ligne.

③ **Perle** Mesurer la glycémie et le potassium : hypoglycémie et hyperkaliémie menacent la vie.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_005 audité

Q72 **EX** **DX.15 · substitué qui vomit**

✅ **C** — Hydrocortisone par voie parentérale

① **Pourquoi c'est juste** Un patient substitué qui vomit doit recevoir l'hydrocortisone par voie parentérale (DX.15), car la voie orale échoue. D'où la carte d'urgence, la trousse d'hydrocortisone injectable et la formation aux doses de stress.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La voie orale échoue chez un patient qui vomit.
- **B** L'arrêt déclenche la crise.
- **D** Elle ne remplace pas le cortisol.
- **E** Le délai expose à la crise.

③ **Perle** Maladie générale sous corticoïde : doubler ou tripler la dose, et passer à l'injection si vomissements.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_005 audité

Q73 EX DX.15 vs DX.2 · hyponatrémie trompeuse

✅ **A** — Insuffisance surrénalienne primaire

① **Pourquoi c'est juste** Hypotension, hyponatrémie et hyperkaliémie : triade de la crise surrénalienne, par déficit en cortisol et en aldostérone (DX.15). L'hyperpigmentation des plis et des gencives signe la forme primaire (excès d'ACTH).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le SIADH ne donne ni hypotension orthostatique ni hyperkaliémie.
- **C** Elle ne donne pas d'hyperkaliémie ni d'hyperpigmentation.
- **D** Elle n'explique pas l'hyperkaliémie et la pigmentation.
- **E** Elle ne donne pas d'hypotension ni d'hyperkaliémie.

③ **Perle** Piège : attribuer l'hyponatrémie à un SIADH ou à un diurétique.

④ **Source** Phase A §4 Démarche diagnostique · LOT_005 audité

Q74 SPE · Rhumatologie DX.5 · dose de prednisone

✅ **C** — 15 à 25 mg par jour

① **Pourquoi c'est juste** Polymyalgie rhumatismale : équivalent prednisone 15 à 25 mg par jour ; artérite à cellules géantes : 40 à 60 mg (DX.5). On exclut d'abord infection et cancer.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de l'artérite à cellules géantes.
- **B** Dose insuffisante pour contrôler l'inflammation.
- **D** Aucune menace visuelle.
- **E** La polymyalgie relève du glucocorticoïde.

③ **Perle** Toute apparition de trouble visuel sous traitement impose un avis sous 24 heures.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_005 audité

Q75 **SPE · Psychogériatrie** DX.6 · escitalopram âgé

✅ **E** — 10 mg par jour

① **Pourquoi c'est juste** Escitalopram : maximum 20 mg par jour, 10 mg chez le sujet de plus de 65 ans ; contre-indiqué en cas d'allongement du QT connu (AIPS Cipralex®) (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose maximale de l'adulte de moins de 65 ans.
- **B** Au-delà de toute dose autorisée.
- **C** Schéma sans fondement.
- **D** L'AIPS limite la dose après 65 ans.

③ **Perle** ECG avant un ISRS à risque de QT chez le sujet âgé.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_005 audité

Q76 **SPE · Infectiologie** DX.9 · mononucléose précoce

✅ **D** — Répéter le test ou sérologie VCA

① **Pourquoi c'est juste** Test hétérophile : sensibilité 87 %, spécificité 91 %, mais faux négatif en première semaine (DX.9). On répète ou on fait la sérologie VCA. Traitement symptomatique ; pas de sport pendant 3 semaines.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le test est faussement négatif en première semaine.
- **B** La rate palpable et les adénopathies postérieures orientent vers la mononucléose.
- **C** Traitement symptomatique dans la forme simple.
- **E** La rate peut se rompre : pas de sport pendant 3 semaines.

③ **Perle** FSC : lymphocytes > 40 % et atypiques > 10 % ; ALAT élevées si le test est négatif.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_005 audité

Q77 SPE · Infectiologie DX.3 · légionellose

✅ **C** — Bêta-lactamine plus macrolide

① **Pourquoi c'est juste** L'antigène urinaire ne détecte que le sérogroupe 1 : un test négatif n'exclut pas la légionellose (DX.3). Le macrolide s'ajoute en cas de gravité ou de légionellose.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'antigène urinaire ne détecte que le sérogroupe 1.
- **B** Gravité et suspicion de légionelle imposent un macrolide et l'hôpital.
- **D** Rien n'oriente vers une grippe isolée.
- **E** On ne retarde pas le traitement.

③ **Perle** Fièvre persistante après 72 heures : chercher empyème, résistance ou autre diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_005 audité

Q78 EX DX.1 · bactériurie asymptomatique

✅ **D** — Chercher une autre cause, sans antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** Chez le sujet âgé confus sans symptôme local, une bandelette positive ne prouve pas la cause (DX.1). La bactériurie asymptomatique ne se traite pas, sauf avant un geste urologique invasif avec saignement muqueux (IDSA 2019). Chercher infection d'un autre site, trouble ionique, médicament, rétention urinaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une bandelette positive sans symptôme est une bactériurie asymptomatique.
- **B** Constantes stables, pas de signe de sepsis.
- **C** Le dépistage de la bactériurie asymptomatique n'est pas recommandé.
- **E** Geste sans indication, source d'infection.

③ **Perle** Traiter une bactériurie asymptomatique est le piège classique de l'examen.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_005 audité

Q79 AP DX.1 · nitrofurantoïne et rein

✅ **C** — Ne pas la prescrire à ce DFGe

① **Pourquoi c'est juste** L'AIPS contre-indique la nitrofurantoïne quand le DFGe est inférieur à 45 mL/min (DX.1). On choisit un autre antibiotique adapté à la fonction rénale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS la contre-indique sous 45 mL/min.
- **B** Une réduction de dose ne lève pas la contre-indication.
- **D** La sensibilité du germe ne change pas la contre-indication rénale.
- **E** Aucun schéma ne la rend acceptable sous 45 mL/min.

③ **Perle** Bactrim® est contre-indiqué au 3e trimestre de grossesse (ictère nucléaire) et élève la kaliémie.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_005 audité

Q80 AP DX.2 · perfusion de potassium

✅ **B** — Dilué, au plus 10 mmol/h, sous ECG

① **Pourquoi c'est juste** Chlorure de potassium : toujours dilué ; si K > 2,5 mmol/L, au plus 10 mmol/h et 200 mmol par jour, 40 mmol/L de solution, avec ECG (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un bolus non dilué expose à l'arrêt cardiaque.
- **C** Débit très supérieur à la limite AIPS.
- **D** L'ECG est nécessaire pendant la perfusion.
- **E** Le potassium se donne toujours dilué.

③ **Perle** L'AIPS contre-indique le potassium en insuffisance rénale.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_005 audité

Q81 **SPE · Néphrologie** **DX.2 · tolvaptan**

✅ **D** — Tolvaptan

① **Pourquoi c'est juste** Hyponatrémie hypovolémique : remplir par soluté isotonique (DX.2). Le tolvaptan est contre-indiqué en cas d'hypovolémie (AIPS Samsca®).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Traitement adapté à l'hypovolémie.
- **B** Bilan étiologique recommandé.
- **C** Mesure utile.
- **E** Surveillance indispensable.

③ **Perle** Limite de correction : moins de 10 à 12 mmol/L en 24 heures.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_005 audité

Q82 **AP** **DX.13 · sildénafil**

✅ **B** — Nitroglycérine

① **Pourquoi c'est juste** L'AIPS contre-indique les nitrés avec les inhibiteurs de la PDE5 : hypotension sévère (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Indiqué dans le SCA sans contre-indication ici.
- **C** Utilisée dans le NSTE-ACS.
- **D** Indication correcte.
- **E** Indiquée après un SCA.

③ **Perle** Toujours demander la prise de sildénafil ou tadalafil avant un nitré.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_005 audité

Q83 **AP** **DX.13 · oxygène**

✅ **A** — Pas d'oxygène

① **Pourquoi c'est juste** Dans le SCA, l'oxygène se donne seulement si la SpO2 est inférieure à 90 % (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'oxygène se donne seulement si la SpO2 est < 90 %.
- **C** Sans indication.
- **D** Aucun bénéfice démontré.
- **E** Sans indication.

③ **Perle** Objectif LDL après SCA : < 1,4 mmol/L et baisse ≥ 50 %.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_005 audité

Q84 **AP** **DX.12 · AVK et thrombolyse**

✅ **D** — Altéplase contre-indiquée par l'INR

① **Pourquoi c'est juste** INR > 1,3 : contre-indication à l'altéplase (AIPS) (DX.12). Plaquettes < 100 000/mm^3 : contre-indication ; PA > 185/110 mmHg à traiter avant thrombolyse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le seuil est un INR supérieur à 1,3.
- **B** On traite la PA si elle dépasse 185/110 mmHg.
- **C** La correction ne lève pas la contre-indication dans la fenêtre.
- **E** Le seuil est 100 G/L ; elles sont normales.

③ **Perle** Une occlusion de gros vaisseau reste accessible à la thrombectomie.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_005 audité

Q85 **AP** **DX.14 · zolédronate et Ringer**

✅ **E** — Voie séparée, NaCl 0,9 %, ≥ 15 min

① **Pourquoi c'est juste** Zolédronate 4 mg dans 100 mL de NaCl 0,9 % ou de glucose 5 %, en au moins 15 minutes, voie séparée ; jamais avec du Ringer-lactate, qui contient du calcium (DX.14).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Aucune solution contenant du calcium ne doit être mélangée.
- **B** La perfusion dure au moins 15 minutes.
- **C** Voie non prévue.
- **D** L'état hydrique se contrôle avant la perfusion.

③ **Perle** Contrôler calcémie et créatinine avant et après.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_005 audité

Q86 **SPE · Endocrinologie** **DX.10 vs DX.15 · thyroïde et surrénale**

✅ **C** — Hydrocortisone d'abord, puis lévothyroxine

① **Pourquoi c'est juste** La lévothyroxine est contre-indiquée en cas d'insuffisance surrénalienne non traitée : il faut d'abord substituer le cortisol (DX.10, DX.15).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiquée en cas d'insuffisance surrénalienne non traitée.
- **B** Le cortisol doit être substitué d'abord.
- **D** Elle peut précipiter une crise surrénalienne.
- **E** Elle ne remplace pas le cortisol.

③ **Perle** Lévothyroxine à jeun, 2 heures avant le fer et le calcium ; 25 µg au départ chez le sujet âgé.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_005 audité

Q87 **AP** **DX.10 · HbA1c et anémie**

✅ **A** — HbA1c faussée : se fier aux glycémies

① **Pourquoi c'est juste** Une anémie fausse l'HbA1c : on se fie aux glycémies (DX.10). Glycémie ≥ 11,1 mmol/L avec symptômes = diabète (ADA).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'anémie fausse l'HbA1c.
- **C** Les glycémies élevées expliquent la polyurie.
- **D** Les mesures sont répétées et concordantes.
- **E** Elle n'élève pas la glycémie.

③ **Perle** Polyurie et soif : hyperglycémie ou hypercalcémie.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_005 audité

Q88 **AP** **DX.15 · cortisol normal en choc**

✅ **C** — Crise non exclue : on poursuit

① **Pourquoi c'est juste** Un cortisol aléatoire « normal » en plein choc n'exclut pas la crise surrénalienne : il est insuffisant pour le stress (DX.15). On traite, puis on confirme par le test à la corticotropine après récupération.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un cortisol normal est insuffisant en situation de choc.
- **B** Le cortisol ne permet pas cette conclusion.
- **D** On traite sans attendre.
- **E** Le test se fait après stabilisation.

③ **Perle** Un cortisol bas sous glucocorticoïde n'a pas de valeur non plus.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_005 audité

Q89 SPE · Toxicologie clinique DX.8 · flumazénil et épilepsie

✅ **E** — Soutien et surveillance

① **Pourquoi c'est juste** Coma sans myosis après sédatif : benzodiazépine possible ; soutien, flumazénil seulement si indiqué (DX.8). Chez l'épileptique traité par benzodiazépines, il est déconseillé, car il peut déclencher des convulsions.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Déconseillé chez l'épileptique sous benzodiazépines : risque de convulsions.
- **B** Elle cible les opioïdes.
- **C** La ventilation est conservée.
- **D** Antidote du paracétamol.

③ **Perle** Flumazénil en soins intensifs : 0,3 mg i.v., jusqu'à 2 mg au total.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_005 audité

Q90 AP DX.8 · syndrome sérotoninergique

✅ **D** — Syndrome sérotoninergique

① **Pourquoi c'est juste** Excitation neuromusculaire, dysautonomie et conscience altérée après un traitement sérotoninergique nouveau ou modifié : syndrome sérotoninergique (critères de Hunter) (DX.8). Arrêt, soutien, avis spécialisé.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le clonus après un nouvel agent sérotoninergique oriente ailleurs.
- **B** Il donne myosis et bradypnée, non clonus et agitation.
- **C** Fièvre et clonus ne sont pas anxieux.
- **E** Elle ne donne pas de clonus ni de fièvre.

③ **Perle** Une fièvre isolée ne suffit pas ; c'est le clonus qui oriente.

④ **Source** Phase B DX.8 §10 · LOT_005 audité

Q91 SPE · Oncologie DX.14 · lyse tumorale

✅ **B** — Hydratation et rasburicase

① **Pourquoi c'est juste** Lyse tumorale (Cairo-Bishop) : hyperuricémie, hyperkaliémie, hyperphosphatémie, hypocalcémie, avec atteinte rénale pour la forme clinique (DX.14). Hydratation et rasburicase 0,20 mg/kg/j, ECG ; pas d'alcalinisation.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle n'est pas recommandée.
- **C** L'hydratation est la base du traitement.
- **D** Une lyse tumorale clinique impose d'agir.
- **E** La rasburicase est le traitement de l'hyperuricémie aiguë ici.

③ **Perle** Rasburicase : jusqu'à 7 jours, sous surveillance d'un hématologue expérimenté.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_005 audité

Q92 SPE · Cardiologie DX.13 · dissection

✅ **B** — Angio-CT avant tout antithrombotique

① **Pourquoi c'est juste** Douleur déchirante, pouls asymétriques ou différence de PA entre les bras : suspecter une dissection aortique et faire un angio-CT avant tout antithrombotique (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les antithrombotiques sont dangereux dans une dissection.
- **C** Elle est dangereuse dans une dissection.
- **D** Le tableau impose une imagerie urgente.
- **E** Contre-indiqué en urgence.

③ **Perle** Un sus-décalage avec troponine restée normale sur des dosages répétés doit aussi faire chercher une dissection.

④ **Source** Phase B DX.13 §13 · LOT_005 audité

Q93 **SPE · Infectiologie** **DX.4 · matériel infecté**

✅ **A** — Retirer le cathéter

① **Pourquoi c'est juste** On draine ou on retire le matériel infecté, car l'antibiotique seul échoue (DX.4). Le contrôle de la source fait partie du traitement de l'infection.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'antibiotique seul échoue sur le matériel infecté.
- **C** Insuffisante pour une bactériémie sur matériel.
- **D** La source reste en place.
- **E** Elles n'autorisent pas à retarder le contrôle de la source.

③ **Perle** Toujours chercher le foyer : poumon, voie urinaire, peau, abdomen, cœur, cathéter.

④ **Source** Phase B DX.4 §13 · LOT_005 audité

Q94 **AP** **DX.6 · PHQ-9 chez le grand malade**

✅ **B** — Rechercher d'abord une cause somatique

① **Pourquoi c'est juste** Un score PHQ-9 élevé chez un patient très malade impose de rechercher d'abord la cause somatique (DX.6). Une maladie somatique ou un médicament produisent les mêmes symptômes ; bilan anormal (TSH, anémie, glycémie, sodium) : traiter la cause et réévaluer l'humeur.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un score élevé chez un patient très malade ne dispense pas du bilan.
- **C** Attribution prématurée.
- **D** Le bilan somatique vient d'abord, sauf idée suicidaire avec plan.
- **E** Délai inadapté.

③ **Perle** Le PHQ-9 dépiste, il ne diagnostique pas.

④ **Source** Phase A §8 Diagnostic positif · LOT_005 audité